单位代码：10220　　中图分类号：C916.0

学　　号：228003121385　　密　　级：

东北石油大学

Northeast Petroleum University

硕士研究生专业学位论文

题　　目	应用行为分析理论下小组工作介入高功能自闭症儿童社交障碍改善的研究--以Y市X机构为例
专业或领域	社会工作
研究方向	社会工作与社区发展
专业硕士生	李广辉
指导教师	姚云云
现场导师	

二〇二五年六月

中国知网　https://www.cnki.net

A study on the intervention of group work for social impairment in children with high-functioning autism under the theory of applied behavior analysis —— Taking X Institution in Y City as an example

by Li Guanghui

Supervisor: Professor Yao Yunyun

A Thesis Submitted to the **Northeast Petroleum University**
In partial fulfillment of the requirement
For the Degree of Master of Law Master Social Work
June, 2025

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

随着全球自闭症发病率的持续攀升，高功能自闭症儿童的社交障碍因其隐蔽性与复杂性，成为介入领域的核心挑战。这类儿童虽具备基础语言能力，但普遍存在社交互动异常、沟通障碍及社交意识缺乏等问题，严重制约其社会融入。传统介入模式因理论系统性不足、泛化训练薄弱等局限，难以满足个性化需求。本研究重点围绕高功能自闭症儿童社交障碍的介入展开，旨在探索有效的介入模式，提升这一群体的社交能力。

本研究选取了四位具有典型且不同表现特点的高功能自闭症儿童，运用应用行为疗法并结合小组工作模式开展服务。为了有效地检验服务的成效性，成效评估采用直接观察法、家长与教师报告法及前后测对比法。评估结论表明，应用行为疗法能显著降低高功能自闭症儿童社交障碍的频率与强度，同时，应用分析疗法与小组工作结合对不同个体社交障碍的改善效果存在差异，这与每个孩子的独特性相关。此外，应用行为分析疗法下小组工作介入对儿童恢复有明显推动作用，孩子们在社交行为频率、质量、认知及情感理解等多方面均有提升。

然而，研究过程中也暴露出理论运用与实际操作贴合不紧密、样本选取少代表性不足、小组工作实务及社工角色面临诸多挑战等问题。基于此，未来建议优化个性化介入方案，利用大数据精准定制介入措施；综合培养社交技能，从基础到高级技能全面提升；建立社交支持系统，涵盖家庭、学校与社区，为儿童营造良好社交环境，进一步提升高功能自闭症儿童社交介入成效。

关键词：高功能自闭症儿童；社交障碍；应用行为分析理论；小组工作

中国知网　https://www.cnki.net

A study on the intervention of group work for social impairment in children with high-functioning autism under the theory of applied behavior analysis —— Taking X Institution in Y City as an example

ABSTRACT

As the global incidence of autism continues to rise, the social disorders of highly functioning autistic children have become the core challenge in the interventional field because of their concealment and complexity. Although such children have basic language ability, they generally have problems such as abnormal social interaction, communication barriers and lack of social awareness, which seriously restrict their social integration. Traditional intervention mode is difficult to meet personalized needs because of the lack of theoretical systematization and weak generalization training. This study focuses on the intervention of social disorders in high-functioning autistic children, aiming to explore effective intervention models and improve the social ability of this group.

In this study, four high-functioning autistic children with typical and different performance characteristics were selected to use applied behavioral therapy and combined with group work mode. In order to effectively test the effectiveness of services, direct observation method, parent and teacher report method and pre-and post comparison method are used for effectiveness evaluation. The evaluation concluded that the application of behavioral therapy can significantly reduce the frequency and intensity of social impairment in high-functioning autistic children, while the combination of applied analytical therapy and group work can improve the social impairment of different individuals, which is associated with the uniqueness of each child. In addition, the effect of group work intervention under the application of behavior analysis therapy has significantly promoted children's recovery, and children have improved the frequency, quality, cognition and emotional understanding of social behaviors.

However, in the process of research, problems such as poor application of theory and practical operation, insufficient selection of samples, and many challenges in group work practice and the role of social workers. Based on this, it is suggested to optimize personalized intervention scheme in the future and accurately customize

中国知网 https://www.cnki.net

intervention measures with big data, comprehensively improve social skills from basic to advanced skills; establish social support system covering family, school and community, create a good social environment for children, and further improve the effectiveness of social intervention for high-function children with autism.

Key words: High-functioning Children With Autism；Social Disorder；Applied Behavior Analysis Theory；Group Work

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景与研究问题.....1
1.1.1 研究背景.....1
1.1.2 研究问题.....2
1.2 研究意义.....2
1.2.1 实践意义.....2
1.2.2 理论意义.....2
1.3 文献综述.....3
1.3.1 自闭症儿童研究.....3
1.3.2 自闭症儿童社交障碍研究.....4
1.3.3 应用行为分析理论研究.....6
1.3.4 应用行为分析理论运用于自闭症儿童社交问题研究.....6
1.3.5 社会工作介入自闭症儿童社交障碍问题研究.....7
1.3.6 研究述评.....8
1.4 概念界定.....10
1.4.1 自闭症.....10
1.4.2 高功能自闭症儿童.....10
1.4.3 社交障碍.....11
1.5 理论视角与研究框架.....12
1.5.1 理论视角.....12
1.5.2 研究框架.....12
1.6 研究方法与研究伦理.....13
1.6.1 研究方法.....13
1.6.2 研究伦理.....15
第 2 章 X 机构高功能自闭症儿童的社交障碍分析.....17
2.1 X 机构高功能自闭症儿童现状.....17
2.1.1 X 机构简介.....17
2.1.2 X 机构高功能自闭症儿童基本情况.....18
2.2 X 机构高功能自闭症儿童社交障碍的表现.....18
2.2.1 社交理解障碍.....18
2.2.2 言语沟通障碍.....19
2.2.3 注意力障碍.....19
2.2.4 情感互动障碍.....20
2.2.5 刻板行为频发.....21

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 X 机构高功能自闭症儿童社交障碍的影响因素 21
2.3.1 生理因素.....21
2.3.2 心理因素.....21
2.3.3 环境因素.....22
第 3 章 应用行为分析理论下高功能自闭症儿童社交障碍的小组工作介入过程 24
3.1 小组方案设计.....24
3.1.1 服务对象选取.....24
3.1.2 需求评估.....26
3.1.3 小组目标.....28
3.1.4 小组活动计划.....29
3.2 小组服务过程.....29
3.2.1 服务前准备.....29
3.2.2 小组活动情况.....30
第 4 章 应用行为分析理论下高功能自闭症儿童社交障碍的小组服务成效评估与分析 41
4.1 评估方法.....41
4.1.1 直接观察法.....41
4.1.2 家长与教师报告法.....41
4.1.3 前后测对比法.....41
4.2 过程评估与结果评估.....41
4.2.1 过程评估.....41
4.2.2 结果评估.....42
4.3 评估结果分析.....46
4.3.1 应用行为分析理论是有效的.....46
4.3.2 个体差异与个性化服务是重要的.....46
4.3.3 持续介入与家庭支持是必要的.....47
第 5 章 研究结论、反思与建议 48
5.1 研究结论.....48
5.1.1 应用行为分析疗法能有效减少高功能自闭症儿童的社交障碍频率与强度 48
5.1.2 应用行为分析疗法与小组工作综合运用改善高功能自闭症儿童社交障碍效果存在个体差异 48
5.1.3 小组工作介入高功能自闭症儿童社交障碍改善有明显效果 48
5.2 反思.....49
5.2.1 理论运用反思.....49
5.2.2 实务介入反思.....49

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.3 社会工作者角色反思.....50
5.3 建议.....51
5.3.1 理论运用建议.....51
5.3.2 实务介入建议.....51
5.3.3 社会工作者角色建议.....53
参考文献.....55
附录 A 高功能自闭症儿童社交行为评估问卷.....58
附录 B 社交反应量表-自闭症儿童社交反应量表.....62
附录 C 满意度调查表-自闭症儿童社交介入满意度调查表.....64

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景与研究问题

1.1.1 研究背景

当下，社会不断进步，人民生活水平日益提高，与此同时，自闭症的发病率也呈现出逐年攀升的态势。2018 年-2023 年，美国自闭症发病率从 1.7%激增至 2.7%，猛增了 10 倍以上。根据美国疾控与预防中心在 2023 年的报告，其新生儿自闭症发病率约为 14.7%，男童发病率更是达到了约 18.5%[1]。2023 年 10 月发布的《中国自闭症儿童发展状况报告》显示，上世纪后期，我国自闭症已从罕见病转变为流行病，发病率和世界各国相当，在 1%左右，自闭症患者数量可能超 1000 万，0-14 岁自闭症儿童很有可能超过 200 万，并且在性别上存在着显著的差别，在我国，男性和女性患病的比例大致为 4-5:1[2]。

自闭症儿童常表现为社会交往障碍、行为刻板重复以及语言沟通障碍等症状，其中社会交往障碍是最为显著的标志之一，主要表现为社交性凝视不、行为模仿困难、无法建立伙伴关系以及无法进行正常游戏等。人类从一开始就是社会的一员，想要在社会中立足、融入并顺应社会，沟通与交往不可或缺。对于自闭症儿童而言，社会交往同样至关重要。但是，很多学者、老师和家长，都忽略了社交技能的培养。为改变这一现状，我们必须探寻更优的教育模式与介入方法，用以改善和弥补自闭症儿童的社会交往缺陷，助力他们尽快适应并融入社会。

由于自闭症的成因尚不明确，且个体差异较大，至今仍无有效的治疗方法。在医学领域，寻求一种高效、安全的生物医疗方法已成为医学界研究的热点。所以当下治疗自闭症主要遵循医教结合、以教为主的原则，借助训练和介入来缓解、改善自闭症儿童的症状。在阅读了大量的文献和电视媒体之后，我们能够看到，针对自闭症儿童的康复训练方法有很多种方式，其中应用行为分析法在全球范围内得到了较为广泛的应用与研究，尤其在国外颇为盛行。从 1960 年代 Ivar Lovaas 教授首次对自闭症儿童进行干预以来，越来越多的学校、教育训练机构以及家庭都开始采用这种方法对自闭症儿童进行介入，目前 Mohammadzaheri、Kilroe、McPhilemy 等学者还在运用应用行为分析法对自闭症儿童展开介入研究，并取得

[1] CDC estimate on autism prevalence increases by nearly 10 percent, to 1 in 54 children in the U.S.https://www.autismspeaks.org/press-release/cdc-estimate-autism-prevalence-increases-nearly-10-percent-1-54-children-us.

[2] 央视新闻网．世界自闭症日：我国每 68 名孩子中约有 1 名患自闭症[EB/OL].https://new.qq.com/omn/20240402/20240402A01PES00.html，2024-4-2.

中国知网 https://www.cnki.net

了一定成效。然而，在我国，与国外相比，这一领域起步较晚，近些年来，只有一些学者对运用应用行为分析法展开了研究，而且大多数研究都是集中在自闭症儿童的问题行为，而在提升自闭症儿童社交交流能力的培训方面，却鲜有涉及。

基于以上现状，研究者不禁提出了一下问题：如果运用应用行为分析法干预高功能自闭症儿童的社交障碍，是否能够达到预期的结果？具体的研究计划，又该怎么设计？在方案实施的前、中、后又需要做哪些准备工作呢？在训练过程中是否会存在问题呢？针对上述问题，本研究拟通过对高功能自闭症儿童的社交障碍的干预，计划运用应用行为分析法对他们存在的社交障碍进行一段时间的介入，以此来验证该方法对于小组工作介入改善自闭症儿童社交障碍是否有着显著的效果。

1.1.2　研究问题

高功能自闭症儿童本身具有社交互动困难、沟通障碍、刻板行为等问题，本文主要着眼于他们的社交障碍问题，在其由熟悉的家庭环境中转移到陌生的机构环境中，由非专业的照顾转移为专业的照顾，由个人转移到同辈群体生活，而在这个过程中，高功能自闭症儿童的社交障碍是否会得到缓解，具体研究问题主要是：第一，应用行为疗法能否有效减少高功能自闭症儿童的社交障碍的频率和强度；第二，小组工作中运用应用行为疗法对高功能自闭症儿童不同个体社交障碍的改善效果是否存在差异。

1.2　研究意义

1.2.1　实践意义

本研究以应用行为分析理论为基础，针对高功能自闭症儿童的社交障碍问题，探索小组工作介入的实践意义。首先，研究通过应用行为分析理论指导，设计系统化的小组介入方案，帮助高功能自闭症儿童掌握社交技能，如眼神交流、轮流对话和情绪识别，提升其社交能力，促进社会融入。其次，小组工作模式为高功能自闭症儿童提供了安全的社交环境，通过同伴互动和角色扮演，增强其社交信心，减少焦虑，改善社交回避行为。最后，研究为高功能自闭症儿童社交障碍的介入提供了新思路，推动应用行为疗法理论在小组工作中的实践应用，为相关领域的研究和实践提供参考。

总之，本研究不仅有助于改善高功能自闭症儿童的社交障碍，还丰富了应用行为分析理论的应用场景，具有重要的实践价值。

1.2.2　理论意义

中国知网　https://www.cnki.net

本研究以应用行为疗法为基础，针对高功能自闭症儿童的社交障碍问题，探索小组工作介入的理论意义，主要体现在以下几个方面：

首先，研究丰富了应用行为疗法理论在高功能自闭症儿童社交介入中的应用。应用行为疗法理论强调通过强化和塑造等策略改变行为，本研究将其应用于小组工作，设计了系统化的社交技能训练方案，拓展了应用行为疗法理论的应用范围，为其在高功能自闭症儿童社交障碍介入中的有效性提供了新的实证支持。

其次，研究促进了小组工作理论与应用行为疗法理论的融合。小组工作强调通过团体动力和同伴互动促进个体成长，而应用行为疗法理论则提供了具体的行为改变策略。本研究将两者结合，为高功能自闭症儿童创造了一个结构化的社交学习环境，既发挥了小组工作的优势，又确保了介入的科学性和有效性，为两种理论的融合提供了新的思路。

最后，研究为高功能自闭症儿童社交障碍的介入提供了新的理论视角。传统的介入方法多侧重于个体训练，而本研究采用小组工作模式，强调了同伴互动和社会环境对高功能自闭症儿童社交能力发展的重要性，为理解高功能自闭症儿童社交障碍的成因和介入路径提供了新的理论视角。

总之，本研究不仅推动了应用行为疗法理论和小组工作理论的发展，也为高功能自闭症儿童社交障碍的介入提供了新的理论依据，具有重要的理论意义。

1.3 文献综述

1.3.1 自闭症儿童研究

自闭症的研究发端于西方，最早是由心理学家发现和研究出来的，从而引发了学界对自闭症的重视。美国著名心理学家里敖·堪纳在 1943 年发表的《情感接触中的自闭性障碍》一文中首次提出“自闭症”一词，这本书不仅揭露了美国社会中存在的儿童自闭症问题，而且也使得这一群体受到世界的重视。自闭症儿童通常有共同的临床表现，如不与人交往、孤僻、语言障碍、简单的动作重复、刻板行为和想象力的缺乏等。

我国最初的自闭症儿童案例是由陶国泰教授于 1982 年确诊的，自此社会各个领域的学者们对自闭症这个脆弱的群体给予了高度重视。伴随着越来越多的自闭症患者，有关自闭症的相关研究也越来越多，在发展的同时不可避免的存在很多不足。

关于自闭症儿童的成因，冯淑瑜、张继永（2003）等指出，自闭症儿童的成因与母体环境的不良影响有很大关系[1]。王瑞珍、周西笛（2007）提出儿童自闭

[1]冯淑瑜, 张继永, 朱明芬, 等. 儿童孤独症 213 例病例分析[J]. 中国儿童保健杂志, 2003,(02):84-86.

中国知网 https://www.cnki.net

症中也有“隐性”的遗传因素[1]。关于儿童自闭症的理论研究，国内的学者多是从生理能力、行为能力、认知能力以及康复教育等几个角度展开的[2]。在实证性的研究中，本文着重从自闭症儿童自身以及自闭症儿童的家庭环境两个层面进行了探讨。本文结合自闭症儿童自身特点，对自闭症儿童的临床表现、成因、诊断和评价标准、矫治方法和效果等多方面展开了研究。从自闭症儿童家庭环境的角度出发，探讨了自闭症儿童家长的教育方式、家庭气氛和家庭需要[3]。李宗华、许永霞（2009）经过对自闭症儿童的调查，认为自闭症儿童的父母面临着很大的外部压力，迫切需要对他们进行有效的指导[4]。雷秀雅、杨振（2010） 研究显示，高效能感家长对自闭症儿童的教养效果由明显影响[5]。吕晓彤和高桥智（2005）指出，近年来，我国自闭症的数量不但增加，但在我国，还没有一套完备的治疗系统，许多自闭症儿童都是在家里或私人机构中进行学前教育，缺少专业的干预[6]。

国外对自闭症儿童的研究历经三个关键阶段（黄伟合，2003）。第一阶段（1940-1950 年代）聚焦医学领域，学者通过症状分析与病例观察，初步揭示自闭症的核心特征（如社交孤立、语言障碍），并提出环境致病假说，强调家庭教养方式与社交环境的影响。第二阶段（1960-1980 年代）引入行为治疗范式，通过系统训练改善症状，同时推动诊断标准的科学化进程，学界开始认识到自闭症是生理遗传与社会环境交互作用的复杂综合征。

进入 1990 年代后，研究进入多学科融合阶段，社会学、心理学、神经科学等领域共同发力，形成 DSM-IV 诊断标准（1994 年）并沿用至今。此阶段通过基因研究（如发现 SHANK3 等候选基因）、神经影像学（如杏仁核功能异常）及干预技术创新（如应用行为分析 ABA），显著提升了自闭症的早期识别与干预成效。研究重点从单一病因探索转向生物——心理——社会模型构建，为现代自闭症干预体系奠定了理论基础。

1.3.2　自闭症儿童社交障碍研究

自闭症儿童的社交障碍作为其核心症状之一，长期以来受到学界广泛关注。该障碍主要呈现三方面典型特征：交往语言行为缺乏、人际情感感知困难及交往主动性不足。早在 1943 年，Kanner 便指出此类障碍的本质是生物系统缺陷与情

[1]王瑞珍, 周西笛. 儿童孤独症临床研究进展[J]. 中国妇幼保健, 2007,(17):2436-2438.

[2]孙永珍, 傅根跃. 我国孤独症的研究现状[J]. 中国特殊教育, 2003,(05):83-86.

[3]黄辛隐, 张锐, 邢延清. 71 例自闭症儿童的家庭需求及发展支持调查[J]. 中国特殊教育, 2009,(11):43-47.

[4]李宗华, 许永霞. 康复教育中孤独症儿童家长的压力及其因应方式研究——基于照顾照顾者视角[J]. 山东教育学院学报, 2009,24(05):1-4.

[5]雷秀雅, 杨振, 刘愫. 父母教养效能感对自闭症儿童康复的影响[J]. 中国特殊教育, 2010,(04):33-36+46.

[6]吕晓彤, 高桥智. 自闭症儿童母亲在养育儿童过程中的需求调查[J]. 中国特殊教育, 2005,(07):47-53.

中国知网　https://www.cnki.net

感系统失调的共同作用，导致儿童无法建立正常社交互动，这一观点奠定了后续研究的理论基础。

美国教育部进一步将自闭症社交障碍的核心问题聚焦于“注意力、社交行为及社会互动”的功能性缺陷。Lordo D N 等学者（2017）细化了障碍的具体表现，强调患者在发起与回应社会互动、解读语言情感信号等方面存在显著困难。[1]为量化评估社交障碍程度，J.N.康斯坦蒂诺等学者编制了《社交反应量表》（SRS），从社交知觉、社交概念、社交交流、社交动机及孤独症行为方式五个维度构建评估体系，为临床诊断提供了标准化工具。

值得注意的是，随着研究深入，自闭症群体的个体差异性愈发凸显，不仅表现为不同患者的症状组合与严重程度存在差异，同一患者在不同成长阶段的社交能力发展轨迹也呈现独特性。这一发现提示实践干预需充分尊重个体特殊性，避免 “一刀切” 的介入模式，从而实现更精准的支持策略。

当前，国内自闭症儿童社交障碍领域的研究主要集中于特殊教育与医学学科，学者们围绕其交往特征、影响因素及干预策略展开深入探索。陈献科和陈靓影（2022）通过视频分析 23 名自闭症谱系障碍儿童与 15 名教师的社会互动，发现自闭症儿童在身体运动的人际同步性上显著低于普通儿童。研究进一步指出，头部旋转等细微动作同样承载社交信息，从注意力机制角度揭示了自闭症儿童在自然互动中的行为模式差异。[2]

在干预策略研究方面，刘巍（2014）采用为期 10 周、共计 20 次的排球互惠式练习，通过结构化的肢体协作与语言互动，有效提升了自闭症儿童的口语表达和肢体交流能力。[3]郭文斌、周念丽和方俊明等特教专家基于融合幼儿园的实践经验，提出将日常活动、游戏环节与课堂学习有机整合的干预模式，成功促进自闭症儿童的社交参与度，增强其校园与社会适应能力。

然而，现有研究也暴露出明显困境：自闭症儿童与普通儿童的互动仍处于相对隔离状态。张珍珍（2019）以杭州市 16 名随班就读自闭症谱系障碍儿童及 585 名同班普通学生为样本，运用同伴提名法与社会网络分析法发现，这些儿童在班级社交网络中处于边缘位置，普遍面临同伴忽视与社交排斥的问题，凸显出改善融合教育环境中社交互动质量的紧迫性。[4]

---

[1]Danielle L N ,Madison B ,Eliana S L , et al.Parents Perceive Improvements in Socio-emotional Functioning in Adolescents with ASD Following Social Skills Treatment.[J].Journal of autism and developmental disorders,2017,47(1):203-214.

[2]陈献科, 陈靓影. 自闭症儿童头部旋转运动人际同步缺陷及其与自闭特征的关系[J]. 科学 通报, 2022,67(08):770-783.

[3]刘巍. “互惠式”练习对学前自闭症儿童人际关系改善的影响[J]. 中国妇幼保健, 2014,29 (19):3089-3091.

[4]张珍珍；连福鑫;贺荟中. 小学随班就读自闭症谱系障碍儿童同伴关系现状研究——以浙 江省杭州市为例[J]. 中国特殊教育, 2019,(09):28-34.

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.3　应用行为分析理论研究

应用行为分析（Applied behavior analysis，简称应用行为疗法）是一门应用心理学的分支学科，主要包括应用的（applied）、行为的（behavior）、分析的（analysis）。本项目提出了一种以行为原则为基础、以系统干预为基础的、具有社会意义的社交活动的方法，并通过实验对其进行验证。这一行为原理已被数千个实验所证实 (Cooper et al., 2020)[1]。

在国外，经过多年的实践研究，已经证实了运用应用行为分析法对自闭症儿童进行干预是行之有效的。在教学中，将目标一步一步地分解成最小的可观察单位，对每个教学步骤都施加刺激，用暗示等辅助手段，反复地重复这一轮教学，直到使患有自闭症的孩子们能够熟练的掌握自己的技巧，并且把结果和目的都记录下来，还会根据孩子们的反映，对孩子们的个性化教育计划进行调整。(胡梦娟, 2015)[2]。

应用行为疗法的关键在于行为的先决条件（A）、行动（B）、结果（C），其中，行为发生的前提（A）和结果（C）是情景变量，帮助推测行动（B）的成因，而行动后的结果（C）则是作出行为反应的决定因素，运用应用行为疗法的原则就是通过该表结果、前提来改变行为的趋向(王洪良, 2020)[3]。

近年来，应用行为分析得到了广泛的重视，许多领域都将应用行为分析理论应用到了自闭症患者的治疗当中。近年来，研究的焦点集中在了问题行为的功能分析和强化策略，自闭症儿童的行为功能分析和强化，以及如何提高自闭症儿童的饮食障碍等方面(孙雯和孙玉梅, 2016)[4]。与其他干预方式相比，运用应用行为分析法的优势是在“评价和培训方案的制订”上更具专业性和针对性，所以使用范围更广，得到了公众的认可(李恩耀等, 2019)[5]。

1.3.4　应用行为分析理论运用于自闭症儿童社交问题研究

应用行为分析，也叫“应用行为疗法”，是一种具有代表性的行为干预方法。这一方式形成了一套对行为的理解、解释、描述和预测的过程，并利用行为变化的理论来干预自闭症儿童的行为，使其行为既与社会准则相一致，又有一定的社

---

[1]Cooper JO, Heron TE, Heward WL. 应用行为分析［M］. 第 3 版。纽约：Pearson, 2020.

[2]胡梦娟, 徐胜, 许家成, 等. 应用行为分析法对自闭症儿童心理理论能力教学成效的个案研究[J]. 现代特殊教育, 2015,(14):44-51.

[3]王洪良, 王妮, 张野. 应用行为分析(ABA)疗法对孤独症儿童介入效果的个案研究[J]. 佳木斯职业学院学报, 2020,36(01):267-268.

[4]孙雯, 孙玉梅. 正向行为支持介入多重障碍儿童扰乱课堂秩序的个案研究[J]. 绥化学院学报, 2016,36(10):109-113.

[5]李恩耀, 于谦, 夏斯曼, 等. 基于应用行为分析的儿童孤独症介入方法探析[J]. 国际精神病学杂志, 2019,46(02):217-220.DOI:10.13479/j.cnki.jip.2019.02.008.

中国知网　https://www.cnki.net

会意义（刘惠军、李亚莉，2007）[1]。20 世纪 70 年代，美国洛瓦思提出了“青少年自闭症”计划，将“离散单元”的概念引入到自闭症儿童的强化行为培养中，这就是行为治疗的雏形。本项目以语言培训为核心，采用“原因（需求）+行动+结果（正/负强化物）”模型，采用功能学的研究方法，对正性行为进行建模。运用行为治疗在临床实践中得到了进一步的发展，并逐步成为了治疗孤独症的主流方法。

1.3.5 社会工作介入自闭症儿童社交障碍问题研究

三种主要的社会工作方式为孤独症病人干预社会互动障碍提供了特定的途径。这方面的研究大多是以三种主要的社会工作方式来介入孤独症病人的社交训练。

（1）介入方法：辛晶晶运用个案工作方法，对自闭症儿童开展了一对一的“语言表达”、“情感表达”、“人际互动”等教学活动，并在此基础上对自闭症儿童开展社交活动的培训[2]。马珊珊运用个案工作方法，从社会支持网的角度探讨了自闭症儿童的社会行为提高[3]。孙晨运用了小组工作技巧，对自闭症青少年在购物过程中的社会行为进行了研究[4]。张婉杰采用个案与小组工作相结合的方式，为自闭症儿童制定了一套适合自闭症儿童社交能力不足的活动方案[5]。

我们可以看到，对于自闭症患者的社会工作干预的具体方式，过去的学者主要采用的是个案工作的方式，其次是小组工作，而社区工作的方式基本不包含，综合运用各种方式来开展社会工作的研究也很少。因为社会工作“三大法则”并非对自闭症患者进行专门的干预，所以仅仅采用这种方式，肯是因为缺乏对自闭症康复训练的专业性的考量，而很难达到真正的效果。

社会工作对自闭症的干预表现出多样化的特点。社会交往是一个比较宽泛的概念，要想培养自闭症患者的社交技能，就必须弄清楚社会交往的具体内容，并对其进行可操作的定义 Travis 从交流、社会知觉、情绪三方面定义了自闭症的社会交往障碍。[6]辛晶晶从“语言表达”“情感表达”“人际互动”这三方面的内容出发设计个案活动，对自闭症儿童进行人际交往技巧的训练[7]。马姗姗从“共同注意力”和“非言语交往行为”这两个方面进行社工介入[8]。张婉杰从“情绪

[1]刘惠军, 李亚莉. 应用行为分析在自闭症儿童康复训练中的应用[J]. 中国特殊教育, 2007,(03):33-37.

[2] 辛晶晶. 自闭症儿童社会交往障碍的社会工作介入研究[D]. 苏州大学, 2017.

[3] 马姗姗. 社会支持网络视角下个案工作在自闭症儿童社交行为改善中的运用研究[D]. 贵州大学, 2015.

[4] 孙晨. 小组工作介入青少年自闭症群体购物环节训练研究[D]. 华中科技大学, 2015.

[5] 张婉杰. 自闭症儿童社会交往障碍的社会工作介入研究[D]. 西北农林科技大学, 2016.

[6] Travis, L. L., & Sigman, M. (1998). Social deficits and interpersonal relationships in autism. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 4(2), 65–72.

[7] 辛晶晶. 自闭症儿童社会交往障碍的社会工作介入研究[D]. 苏州大学, 2017.

[8] 马姗姗. 社会支持网络视角下个案工作在自闭症儿童社交行为改善中的运用研究[D]. 贵州大学, 2015.

中国知网 https://www.cnki.net

控制能力”“认知能力”“生活自理能力”“社会交往能力”这四个维度，为社会工作者制定了相应的干预计划[1]。吕汉城研以“技能取向”、“结果取向”和“综合取向”三个维度为依据，探讨了同伴干预对提高自闭症儿童社交能力的有效性[2]。但笔者认为这三个维度过于抽象，不能达到可操作的目标，很难对其进行评价。

上述对社会交往的具体包括方面进行的分类均有其合理之处，但是同时也可以看到，在涉及到社会交往这一概念时，并没有一个统一的可操作的定义，这样的不一致性在给予学者以较大的自由度的同时，也会导致其逻辑上的混乱，使得活动的设计不具有系统性。

（2）评估：结果评价是社会工作干预自闭症患者社交活动有效性的一个重要指标。张婉杰通过三种方式来评价社会工作干预的有效性：一是使用量表，选择自闭症儿童行为量表，分别对其进行前后测试；二是行为观察；三是跟踪访问。从评价方法上看，自闭症儿童行为量表是一种以自闭症为主的测评工具，而不是一种对社会交往能力进行测评的工具，所以在培训内容上没有太多的针对性；行为观测法、跟踪法等也能成为评价的基础，但其主观性、客观性不强；辛晶晶所采用的评价方法是以多个主体来评价，其中包括了对案主的案例评价，对被服务对象家长的评价，以及对机构督导的评价，这一评价方法涵盖了多方，但是主观性也很强。从整体上看，社会工作实践中对社会工作实践的评价，多采用多元主体多维度的评价方法。有针对性，客观的评价还很少。

马姗姗就共同注意力和非言语行为两个维度细分了若干问题，对自闭症儿童在回答问题时的正面、滞后、负面反应的数量进行测试与分析，最后得到有关的结论。但是，马珊珊所提出的问题，更多是基于学理上的理论架构，很少涉及到被干预者的真实问题。所以很难准确地反映出真实的情况，评价的结果也会大打折扣。

1.3.6　研究述评

经过上文的文献回顾，笔者认为，上文的文献对本文的研究有以下启示：

首先，现有研究表明，张婉杰等认为单纯依赖社会工作实务方法（如个案辅导、小组活动）难以满足自闭症儿童的专业需求[3]。本研究创新之处在于整合应用行为分析（ABA）与小组工作模式，既保证干预的专业性（如强化系统设计），又发挥团体动力对社交能力的促进作用。文献显示，胡梦娟等认为 ABA 在个体训练中效果显著，但其在团体场景中的适用性尚未充分验证[4]。本研究通过构建

[1] 张婉杰. 自闭症儿童社会交往障碍的社会工作介入研究[D]. 西北农林科技大学, 2016.

[2] 吕汉城. 同伴介入对自闭症儿童社会交往能力提升的成效研究[D]. 长春理工大学, 2019.

[3] 张婉杰. 自闭症儿童社会交往障碍的社会工作介入研究[D]. 西北农林科技大学, 2016.

[4] 胡梦娟, 徐胜, 许家成, 等. 应用行为分析法对自闭症儿童心理理论能力教学成效的个案研究[J]. 现代特殊

中国知网　https://www.cnki.net

“强化-示范-塑造” 三位一体干预体系，为 ABA 理论在小组工作中的应用提供了实证依据，填补了团体干预的理论空白。其次，吕汉城认为既往研究因缺乏统一的社交能力操作化定义[1]，导致训练目标模糊。

结论：现有研究已构建较为完整的理论与实践框架，但在文化适配性、长期效果追踪、跨学科协同等方面仍存在显著缺口。未来需以“精准介入+社会融合”为导向，通过技术创新、政策完善与社会参与，推动自闭症儿童社交介入从“生存保障”向“生命质量提升”转型。研究重点应聚焦于开发文化特异性介入模式、建立多学科协作机制、完善全生命周期支持体系，以及利用数字技术提升介入效能，最终实现自闭症群体的社会融入与全面发展。

除此之外，笔者也发现了以往文献研究中的一些不足之处。

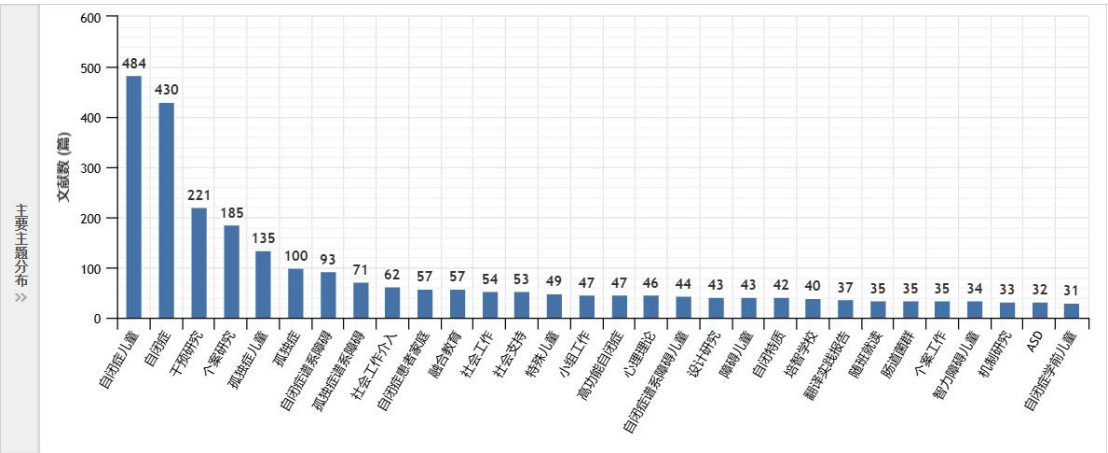

图 1.1 自闭症文献主题分布数据图

Fig. 1.1 Research Flowchart

既有研究对于高功能儿童自闭症群体的关注不足。通过分析图 1.1 中关于自闭症文献的具体主题分布，可以发现目前自闭症患者中受到关注的大多数是儿童。既有自闭症康复训练介入方法具有学科局限性。从图 1.1 中可以看出，目前针对自闭症患者的康复训练多是从心理学或精神病学等病理学的视角出发，运用心理学理论或音乐治疗、音乐电疗、游戏治疗等方式进行介入。这些理论和治疗方法，有一定的专业性，但却集中在了心理学和精神病学的领域，缺乏社会工作领域的介入方法。

以往关于自闭症康复训练的文献，涉及的层面都比较泛化。自闭症是一种综合性的障碍，有着多样化的症状。在对自闭症进行康复训练时，需要明确此种康复训练所针对的具体问题是什么，这样才可以更有效地去解决问题。但也可以发现，在介入方法层面，缺乏“在生活中康复”这一更“接地气”的视角，也就缺

教育, 2015,(14):44-51.

[1] 吕汉城. 同伴介入对自闭症儿童社会交往能力提升的成效研究[D]. 长春理工大学, 2019.

中国知网 https://www.cnki.net

少了对实际生活交往技能的训练，本文针对自闭症儿童的社会交往障碍展开研究，更贴合如今儿童自闭症群体的现实需要。

既往自闭症康复训练的介入主体具有单一性。结合上文分析，可以发现，由于自闭症康复训练的介入视角具有病理性，其介入主体大多为精神科医生或心理医生。只有少量文献（共计 73 篇）提到了社工的介入，而这种介入多是针对于自闭症患者的家庭的。因此，社工直接介入自闭症患者的康复训练，在我国学术研究中是一个较新的领域。

综上，可以发现，社工介入儿童自闭症群体的社会交往障碍，在介入主体、介入方法、介入的具体问题、评估方法上，都有着一定的创新性。 而就介入的理论方面，国内学者虽然提出了应用行为分析视角对自闭症的康复训练有着较好的效果，但其一，主要集中在理论方面的探讨，并未与实务进行结合；其二既有研究较少将此理论聚焦到对自闭症患者某一具体问题的解决，因此有些泛化。在本文中，笔者将尝试着将应用行为疗法理论与社工小组实务结合起来，聚焦儿童自闭症群体的社会交往障碍，探寻社工小组与应用行为疗法治疗法相结合的新模式。

1.4　概念界定

1.4.1　自闭症

自闭症（autism）的概念最初是在 20 世纪 10 年代出现,是由瑞士精神病医生 Eagen Bleuer 提出。1943 年, Kanne 医生在论文《情感交流的自闭性障碍》，明确提出了“自闭症”这一概念，认为它是一种广泛性的发育障碍，指这些儿童看起来像被封闭在自己的世界里,与外界隔离（霍力嫔，2009）[1]。美国心理病学会于 2013 年 5 月发表的心理疾病诊断统计手册第五版（DSM-Ⅴ）中，正式公布了自闭症谱系障碍的概念，统称为自闭症谱系障碍(ASD)，主要表现为社会交流障碍、限制性兴趣、重复行为等两个大方面（叶家涛等人，2014）[2]。

总而言之，自闭症是一种发育障碍，是因神经心理功能异常而导致交流、社会交往和行为三方面同时出现严重问题的综合征，具体表现在三个方面，即社会交往缺陷、沟通障碍与刻板性重复行为，起病于 3 岁前。

1.4.2　高功能自闭症儿童

自闭症谱系障碍（Autism Spectrum Disorder, ASD）儿童的概念是一个涉及

[1]霍力嫔. 孤独症儿童人际交往训练个案研究[D]. 内蒙古师范大学, 2009.

[2]叶家涛, 陈顺森, 王文强. 自闭症谱系障碍者的感觉特点及诊断价值分析[J]. 牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版), 2014,(01):131-133.DOI:10.13815/j.cnki.jmtc(pss).2014.01.050.

中国知网　https://www.cnki.net

神经发育、行为特征和社会适应的复杂体系。根据 DSM-5 和 ICD-11 的诊断标准，自闭症儿童的核心特征表现为社交沟通障碍（如眼神回避、对话理解困难）和重复刻板行为（如固定仪式、狭窄兴趣），同时伴有症状严重程度的显著异质性。近年来，随着诊断标准的扩展，谱系概念逐渐涵盖阿斯伯格综合征、未特定型自闭症等亚型，形成更具包容性的定义框架。高功能自闭症儿童与自闭症儿童的关系是谱系概念下的亚型分类关系。根据当前主流诊断标准（DSM-5 和 ICD-11），高功能自闭症（High-Functioning Autism, HFA）属于自闭症谱系障碍（Autism Spectrum Disorder, ASD）的重要亚型，其核心特征与典型自闭症高度一致，但在认知水平、语言能力和社会适应表现上存在显著差异。

高功能自闭症，属于自闭症的一种亚类型，约占自闭症群体的 1/5。高功能自闭症儿童在社会交往和互动沟通方面存在轻微异常或发育障碍，同时会伴随重复、刻板行为和局限的兴趣，在学校、家庭职业和社会功能各个方面均会存在一些困难。本文的研究中的高功能自闭症儿童是 8-14 岁，且他们的智力水平接近正常，但是他们存在情绪理解困难、性别标签冷漠、社交互动局限、缺乏语言能力等问题。

1.4.3 社交障碍

笔者在查阅文献过程中，发现学者们对这一概念的界定并不完全一致，王姣艳从三方面出发将社会交往障碍进行了阐述，即："人际知觉迟钝、人际卷入水平不足和在人际交往中多处于被动地位"[1]。Travis 从交流、社会知觉、情绪三方面定义了自闭症的社会交往障碍[2]。其中，Travis 又将社会知觉定义为无法运用自身的信念、渴望、情绪、意图的框架体系对他人的行为进行理解。美国加利福利亚大学洛杉矶分校设计的《人际交往能力评估问卷》中将人际交往能力划分为了五种维度：主动交往、适当拒绝、自我表达、冲突管理、情感支持[3]。结合四个月以来对 X 机构高功能自闭症儿童的观察，进一步发现高功能自闭症儿童在社交层面呈现出更为复杂且特殊的状况。高功能自闭症儿童在社交层面呈现社交障碍：其一，社交理解障碍，X 机构高功能自闭症儿童在认知能力与语言水平相对较好的情况下，在解读社交信息、理解社交规则、感知他人意图和情感方面存在明显困难，进而影响其正常社交互动与人际关系发展；其二，言语沟通障碍，X 机构四名高功能自闭症儿童的言语沟通障碍表现为在语言能力相对较好的基

[1] 王姣艳, 程兰春. 以应用为导向的儿童康复专业实践教学现状分析与建议——以南京特殊教育师范学院(筹)为例[J]. 现代特殊教育, 2015,(08):62-66.

[2] Travis, L. L., & Sigman, M. (1998). Social deficits and interpersonal relationships in autism. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 4(2), 65–72.

[3] Kanning ,Peter U.Development and validation of a German-language version of the Interpersonal Competence Questionnaire (ICQ).[J].European Journal of Psychological Assessment,2006,22(1):43-51.

中国知网 https://www.cnki.net

础上，依然在表达、理解和语言应用层面存在问题，导致社交互动受阻；其三，注意力障碍，X 机构四名高功能自闭症儿童多在维持专注、选择性注意及注意力转移等方面存在持续性困难，从而导致学习或日常活动受到显著影响；其四，情感互动障碍，X 机构四名高功能自闭症儿童在情感感知、表达及回应他人情感方面存在显著困难，尽管他们在认知和语言能力上相对较好，但仍难以建立自然、流畅的情感连结。

1.5　理论视角与研究框架

1.5.1　理论视角

应用行为分析（Applied Behavior Analysis，以下文章中简称为应用行为疗法）是行为介入的一种，最基本的原理就是“刺激-反应-强化”。具体来说是指人们在尝试理解、解释、描述和预测行为的基础上，运用行为改变的原理和方法对行为进行介入，使之具有一定的社会意义的过程，即对行为分析的结果进行应用。与传统的行为疗法相比，一方面，应用行为分析强调对行为功能的分析，从而发现隐藏在行为背后的功能与目的，而不是简单地消除或建立行为。另一方面，应用行为分析十分强调个体化，要求针对不同的案主采取不同的刺激和强化策略。Howard 认为，应用行为分析治疗方法具有以下主要特点：一是适宜个体在各种技能训练的介入；二是通过运用多样的行为分析方法，帮助个体获得新的技能，减少负面行为的发生；三是应用行为疗法介入已经从最一开始的针对个体的介入慢慢发展成为了一种团体辅导的模式；四是应用行为疗法 训练可以在家庭和专业机构中进行，也可以通过循序渐进的系统训练逐步转移训练场地，到其他环境下进行[1]。

1.5.2 研究框架

下图呈现针对高功能自闭症儿童社交障碍的研究介入流程：首先聚焦“高功能自闭症儿童社交障碍”问题，选取 X 机构 4 名儿童为案例；通过参与式观察法、访谈法收集信息，梳理理论基础与治疗方法，进行理论分析；随后运用“ABA 治疗法+小组工作”实施介入；最后从直接评估、间接评估两维度开展成效评估，形成“发现问题——案例选择——方法分析——介入实施——效果评价”的完整

[1] Howard J S, Stanislaw H, Green G, et al. Comparison of behavior analytic and eclectic early interventions for young children with autism after three years[J]. Research in Developmental Disabilities, 2014, 35(12):3326-3344.

中国知网　https://www.cnki.net

研究路径，系统解决目标群体的社交障碍问题。

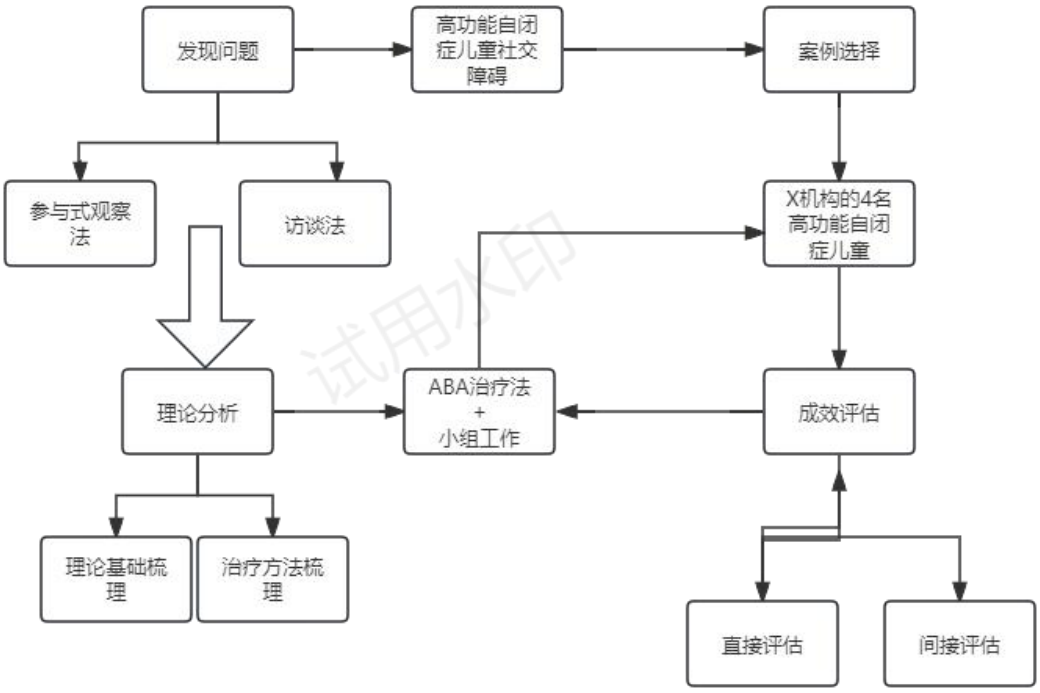

图 1.2　研究框架
Fig. 1.2 Research Framework

1.6　研究方法与研究伦理

1.6.1　研究方法

（1）参与式观察法

观察法分为非参与式观察法与参与式观察法，非参与式观察主要是实地的、结构式观察，参与式观察主要是实地的、非结构式的观察。笔者在 X 机构进行了为期 3 个月的实习，3 个月的时间中全程参与了 X 机构对案主提供的康复服务，一方面是为了与案主建立较为信任的专业关系，另一方面则是为了在实地的观察中发现案主的潜在需求。3 个月的观察的过程是一个漫长的过程，在此过程中，笔者抱着发现案主需求的目的，但并没有严格圈定和限制观察所涉及的方面，因此属于参与式观察法。

表 1. 1 参与观察情况表
Table 1.1 Participation Observation Record Form

中国知网　https://www.cnki.net

观察对象	观察次数	观察日期	观察地点	观察内容
A	4	2024-04-02--2024-04-12	机构	数学认知、注意力、语言表达、兴趣专注度
B	4	2024-04-06--2024-04-12	机构	对话灵活性、非语言表达
C	4	2024-04-10--2024-04-18	机构	图形认知、兴趣专注度、需求表达、情绪描述
D	4	2024-04-16--2024-04-22	机构	注意力、语言表达、非语言沟通、情感表达

（2）访谈法

陈向明认为："访谈是一种研究性交谈，是研究者通过口头谈话的方式从被研究者那里收集第一手资料的一种研究方法[1]。"裴娣娜将访谈定义为研究性交谈，是以口头方式，根据被询问者的答复搜集客观的、不带偏见的事实材料，以准确地说明样本所要代表总体的一种方式[2]。

本研究采用质性研究范式下的访谈法开展资料收集工作。具体而言，通过面对面半结构化访谈形式，分别与自闭症儿童监护人及特殊教育机构专业人员进行深度对话，旨在获取关于研究对象生存状态、介入需求及社会支持系统的原始研究数据。这种研究方法的选择，既遵循了质性研究强调的 "主体间性" 原则，又通过多维度资料互证确保了研究数据的信度与效度，为后续理论建构提供了坚实的经验基础。访谈过程严格遵循知情同意原则，采用录音转译与现场记录相结合的方式，对访谈内容进行系统化编码分析，最终形成具有理论饱和度的研究素材。

表 1.2 半结构访谈对象基本情况表
Table 1.2 Semi-structured Interviewee Basic Information Form

对象	性	年	地点	次数	访谈内容

[1]陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 教育科学出版社，2000

[2]裴娣娜. 教育研究方法导论[M]. 安徽教育出版社，1995

中国知网　https://www.cnki.net

	别	龄			
A 家长	男	41	机构会议室	2	A 的日常表现、问题、需求、家庭支持系统、强化物选择偏好、社交技能泛化困难、政策需求
B 家长	女	62	机构会议室	2	B 在家庭的表现、替代行为有效性、教师沟通障碍、经济援助需求
C 家长	女	37	机构会议室	1	机构介入策略评价、共病管理挑战、社区资源利用障碍、家长互助需求
D 家长	女	37	机构会议室	2	社交技能迁移困难、情绪管理策略、学校融合教育支持、喘息服务需求
机构教师 1	女	25	机构会议室	1	ABA 理论应用难点、小组互动引导策略、家长沟通技巧、跨学科协作需求
机构教师 2	女	24	机构会议室	2	高功能儿童行为评估方法、替代行为设计案例、自然场景泛化训练、政策支持建议

1.6.2 研究伦理

（1）知情同意原则

指研究者有责任向研究对象及相关人员，如自闭症儿童的家长、机构教师等，详细且清晰地阐述研究的目的、所采用的方法、研究开展的具体流程，以及可能产生的影响等各方面信息。在充分沟通后，获取他们自愿给出的书面同意。在本研究中，需向家长说明应用行为疗法结合小组工作的介入方式、数据收集途径、孩子参与小组活动的内容与预期效果等，让家长在全面了解的基础上，决定是否同意孩子参与研究。

（2）尊重原则

要求研究者尊重研究对象的隐私，不随意泄露其个人及家庭信息；尊重他们的意愿，比如若自闭症儿童不愿参与某些活动，应予以理解和尊重；尊重其人格尊严，避免任何形式的贬低或伤害。就本研究而言，在观察记录自闭症儿童行为时，对涉及隐私的敏感信息应妥善保护；在设计小组活动环节，充分考虑儿童的意愿，确保活动安排符合他们的心理接受程度。

（3）公平对待与非歧视

意味着所有研究对象，无论自闭症儿童的病情严重程度、性别、年龄、家庭

中国知网 https://www.cnki.net

背景等因素如何，在研究过程中都应得到一视同仁的公平对待。不会因这些因素而在服务提供、资源分配、研究关注程度等方面有所差别。在本研究里，选取服务对象时不以病情轻重为唯一标准，而是综合考量；在小组工作介入过程中，为每一位儿童提供相同质量的介入服务与支持，确保每个孩子都有平等的机会提升社交能力。

中国知网　https://www.cnki.net

第 2 章　X 机构高功能自闭症儿童的社交障碍分析

本章系统剖析了 X 机构高功能自闭症儿童的社交障碍现状与影响因素。研究采用参与式观察与深度访谈，发现 4 名 8-14 岁服务对象存在社交互动异常、沟通困难、意识缺乏、认知不足及刻板行为频发等问题。其障碍成因涉及生理、心理与环境多维度。这些因素相互交织，影响了自闭症儿童的社会交往。

2.1　X 机构高功能自闭症儿童现状

本研究基于质性研究范式，采用参与式观察与深度访谈相结合的方法，系统探究X机构高功能自闭症儿童的社交障碍特征。研究者于 2024年4月至2024 年7月期间，以机构实习社工身份深度参与机构日常教学，通过每日 8 小时沉浸式观察、个案跟踪记录及多维度资料收集，构建起对服务对象的立体认知。

2.1.1　X 机构简介

榆林星缘自闭症儿童康复教育中心位于榆林市芹涧路综艺巷 15 号，创办于 2013 年，是由自闭症儿童家长创办的民办非营利社会组织，在榆林市民政局民间办公室正式登记注册，学校占地面积约 2000 平方米，户外活动场地约 400 平方米，该校创办以来不断改善办学条件、更新办校理念，现具有一定规模，师资队伍稳定，专业水平较高。中心成立以来，深受市民政局、市残联以及市慈善协会、陕西省宋庆龄基金会榆林分会等单位的大力支持和关心，并得到社会各界爱心企业以及爱心人士的资助。2013 年至今，已对 200 多名自闭症儿童及其相关障碍儿童进行过康复训练，使其各方面能力得到很大的提高，并得到家长的一致好评和肯定。

X 机构目前有 8 名专职教师、一名主任以及一位理事，目前机构主要的业务有为 2-17 周岁孤独症、发育迟缓、语言落后等心智障碍儿童和青少年及其家庭提供全方位综合咨询服务即专业康复、融合教育的解决方案并且与笔者所在学院社工专业达成合作，每年都会有社工专业学生去该机构进行实习，今年由笔者作为学生志愿者的负责人开展的“相伴星途”社会工作支持自闭症儿童社会融入的项目。从 X 机构的组织架构和业务构成可以看出，X 机构目前专业人员较为缺乏，业务围绕着机构“在生活中康复，在康复中生活”的理念，比较日常和生活化。X 机构的训练环境有其自身的优势，即接地气，贴合服务对象更实用性的需要。因此，X 机构的此种情况，一方面给予了笔者较大的空间进行主题式的社工小组服务，使笔者的进入和选择案例具有了可行性。另一方面，由于 X 机构的训练内容与笔者开展的社工小组有所差别，所以在一定程度上可以排除其他因素

中国知网　https://www.cnki.net

对小组成效的干扰，从而得以更加客观地验证 应用行为疗法指导下的小组工作介入高功能自闭症儿童社交障碍的可行性与有效性。

2.1.2　X 机构高功能自闭症儿童基本情况

X 机构现今日常接待的服务对象共有 26 名。这 26 名服务对象的年龄均在 5 岁至 14 岁之间，他们之中接受 X 机构服务时间最长的为 5 年，最短的为 4 个月，就症状轻重而言，也存在着轻度、中度、重度的区别。

轻度自闭症也称作高功能自闭症，目前 X 机构共有 4 名高功能自闭症儿童，这五个孩子的年龄主要分布在 8-14 岁，且他们的智力水平接近正常，但是他们存在情绪理解困难、性别标签冷漠、社交互动局限、缺乏语言能力等问题。

表 2.1　X 机构高功能自闭症儿童基本情况表
Table 2.1 Basic Information Table of High-Functioning Autistic Children of X Institution

对象	性别	年龄	认知	语言表达与沟通
A	男	11	10 以内的加减法可掌握，复杂应用题困难；汉字学习需反复示范；注意力不集中，但对汽车画册高度专注	能清晰表达需求（如要玩具），但社交对话中缺乏灵活调整能力，语气生硬
B	男	12	可阅读简单故事但难理解寓意；复杂美术知识吸收慢；注意力易被声音干扰，拼图时专注	语句流畅但聊天中缺乏话题调整能力，忽视对方兴趣信号
C	男	14	能识别几何图形名单组合困难；注意力易分散（如装饰画），户外观察昆虫时专注	可表达喜好但社交中词不达意
D	女	8	数字排序能力较强，但实际应用（如购物计算）困难；听音乐易分心，乐高积木专注	能表达感受但对话缺乏注定询问，回应延续话题能力弱

2.2　X 机构高功能自闭症儿童社交障碍的表现

2.2.1　社交理解障碍

中国知网　https://www.cnki.net

X 机构的四名高功能自闭症儿童虽在认知与语言表达上具备一定基础，但在社交理解层面仍存在显著障碍。在日常团体游戏与课堂讨论中，他们难以解读他人的非语言社交信号，常对同伴的皱眉、摆手等拒绝性肢体动作视而不见，甚至将对方的不耐烦误读为友好回应。例如在角色扮演活动里，即便同伴通过夸张的摇头和后退动作表示拒绝某个游戏设定，他们仍会固执地重复原有提议，无法根据情境调整互动方式。此外，他们对语言的隐含意义理解困难，当同学说“我有点累了”（暗示暂停游戏），往往仅字面理解为身体疲惫，无法领会对方想结束活动的意图。在情感共鸣与社交规则认知上，这些儿童缺乏对他人情绪的共情能力，面对同伴哭泣时常常手足无措，甚至会因继续谈论自身感兴趣的汽车模型等话题而加剧对方负面情绪；同时，难以区分不同社交场景的行为规范，常在图书馆大声讨论模型车，忽视公共场所的安静要求，导致难以融入集体，始终与同龄人保持社交距离。

2.2.2 言语沟通障碍

X 机构的四名高功能自闭症儿童虽具备基础语言能力，但在言语沟通层面存在显著障碍。在日常观察中发现，他们普遍存在沟通主动性缺失的问题，极少主动开启对话，面对他人询问时，常以沉默、单字或重复性语句回应。如课间休息时，即使身边同学热情邀请“一起玩积木吧”，他们也仅用“嗯”“不”简单作答，甚至毫无反应，继续独自摆弄玩具，导致社交互动难以展开。

在理解他人话语方面，这些儿童对隐含意义、隐喻及社交暗示的解读能力薄弱。当志愿者用“有点口渴了”暗示希望帮忙拿水时，他们无法领会背后需求，仅机械回应“喝水好”，无法采取实际行动；面对反讽语句，更会将玩笑话当真，造成沟通误解。

语言表达的刻板性也是突出问题。他们常重复动画片台词或他人说过的语句，如反复念叨“汽车要出发了”，即便场景与汽车毫无关联；在不同社交场景中，始终使用固定句式，如在课堂提问和日常聊天时，都以同样生硬的语气和措辞回应，难以根据对方身份、场景调整语言风格，使得交流缺乏灵活性与自然感，严重阻碍其融入社交环境。

2.2.3 注意力障碍

X 机构的四名高功能自闭症儿童的注意力障碍在多个维度显著显现。首先，他们对环境信息的筛选能力不足，极易被无关刺激吸引而分散注意力。例如在课堂教学时，窗外飞过的小鸟、走廊里的脚步声，甚至书页翻动的细微声响，都能瞬间打断他们听讲的状态，导致难以专注于教师讲解的内容或黑板上的教学重点。

其次，在持续性注意力方面存在明显短板。无论是完成拼图、绘画等手工任

中国知网 https://www.cnki.net

务，还是参与小组讨论活动，他们都难以长时间维持专注。往往在开始几分钟后便出现注意力涣散，将手中的画笔丢开，转而漫无目的地在教室内走动，或反复开关抽屉，无法按要求完成既定任务。

再者，这些儿童在转移注意力方面表现出僵化特征。当从一项活动转换到另一项活动时，如课间休息结束后回到座位准备上课，他们很难快速将注意力从休息时的状态切换到学习任务上。常沉浸于休息时的思绪或动作（如反复回味课间玩过的玩具），对教师“准备上课”的指令反应迟缓，需要多次提醒才能进入新的活动状态。

最后，在选择性注意力上同样存在缺陷。在复杂的社交或学习场景中，他们无法聚焦于关键信息。例如在小组合作搭建积木时，不能专注于团队分工和搭建目标，反而执着于积木的颜色排列顺序，或反复调整某一块积木的位置，忽略团队成员的协作需求和整体搭建进度，导致难以融入集体活动，严重影响任务完成和社交互动效果。

2.2.4　情感互动障碍

X 机构的四名高功能自闭症儿童在情感互动层面存在障碍，尽管其认知与语言能力相对较好，但在情感感知、表达及回应他人情感时仍表现出显著困难，具体体现在以下几个方面。

首先，情感角色认知模糊，亲疏情感表达无差异。他们难以分辨不同人际关系中的情感边界，对亲人、同学、陌生人采用同一套情感互动模式。例如，面对母亲接送时的拥抱需求，可能仅机械性抬手回应，与对待陌生志愿者的肢体接触反应无明显区别；在小组活动中，会对刚认识的同伴直接说出私密家庭信息，缺乏对亲密关系与社交距离的感知，导致他人因情感互动错位而产生不适感。

其次，社交情感规则缺失，互动行为常偏离场景需求。儿童们普遍缺乏对情感互动规则的认知，无法理解不同场景下的情感表达规范。在班级生日会上，他们可能在同伴吹蜡烛时突然大喊大叫，或在他人收到礼物时无任何祝贺反应，反而自顾自讨论蛋糕的颜色；在模拟“安慰受伤同伴”的场景中，部分儿童会机械重复“别哭了”，却无拥抱、递纸巾等共情行为，甚至因对方持续哭泣而表现出烦躁，拍打桌子要求“安静”，暴露了情感互动规则的严重缺失。

最后，情感场景识别障碍，表达方式与情境脱节

他们对不同社交场景的情感氛围缺乏感知能力，常做出与场景情感基调不符的行为。例如，在观看动画片的悲伤情节时，他们却因画面中出现喜欢的汽车角色而兴奋拍手；在医院探望生病的同学时，会因看到病房里的医疗设备而转移注意力，沉迷于观看新事物，忽略对“生病”同学的情感关怀，导致互动场景中的情感联结断裂。

中国知网　https://www.cnki.net

这些情感互动障碍严重影响了儿童与他人建立深层社交关系的能力，使其在集体中常处于情感隔离状态。尽管语言能力尚可，但因缺乏情感共鸣与互动策略，导致社交互动流于表面，难以融入正常的社交网络，亟需针对性的情感认知干预与场景化训练。

2.2.5 刻板行为频发

实习过程中，笔者观察到 X 机构部分高功能自闭症儿童存在典型刻板行为表现。这些高功能自闭症儿童的行为动作维度，呈现持续性拍手、身体摇晃、物品旋转等重复性动作，且发生频率高、自我控制机制薄弱，即便经志愿者与教师介入劝阻，仍难以即时中止。此外，生活习惯层面亦显刻板特征，如物品摆放须恪守固定模式，若顺序被打乱或物品位置改变，便会引发强烈焦虑、烦躁情绪，甚至出现情绪失控现象。

2.3 X 机构高功能自闭症儿童社交障碍的影响因素

2.3.1 生理因素

X机构4名高功能自闭症儿童的社交障碍或与遗传易感性及神经发育异常紧密相关。2009 年 Rosenberg 的双生子研究证实，孤独症谱系障碍（ASD）存在显著遗传倾向，同卵双生子共患为 60%-90%，远超异卵双生子的 10%-20%，尽管目前鉴定的 SHANK3、AUTS2 等 100 余个候选基因仅能解释 20%病例，但遗传学因素仍是不可忽视的风险基础。

从神经生物学层面来看，基因变异可能通过干扰神经发育进程，直接影响儿童的社交功能。例如，NLGN3 基因异常会破坏突触形成，导致儿童在社交互动中难以建立有效的神经连接，表现为对话时话题转换生硬、无法及时捕捉他人社交暗示；RELN 基因影响神经元迁移，致使大脑网络连接紊乱，进而出现集体活动中难以融入、独自重复特定行为等症状。同时，神经影像学研究揭示的脑区功能异常，在这 4 名儿童身上也有明显体现，海马体体积缩小可能导致其记忆加工障碍，难以记住社交规则与过往互动经验；杏仁核过度活跃使他们对情绪信息过度敏感或反应不足，如面对同伴哭泣时无动于衷；默认模式网络（DMN）连接异常，则直接削弱了他们对社交场景的理解能力，在集体生日会、小组合作中无法判断自身行为是否恰当，常做出不合时宜的举动。这些遗传与神经层面的因素相互作用，最终外显为社交沟通缺陷、重复刻板行为等核心障碍，深刻影响着儿童的社交发展。

2.3.2 心理因素

中国知网 https://www.cnki.net

在 X 机构的 4 名高功能自闭症儿童身上，“焦虑 ——回避”与“动机缺失”的双重心理机制显著加剧了他们的社交障碍。在社交焦虑层面，儿童 A 在集体游戏中曾因尝试加入却误碰他人玩具，遭到同伴指责后，便长期对团队活动表现出抗拒，活动开始前就会躲在角落；儿童 B 面对陌生老师提问时，会因害怕回答错误而浑身紧绷、拒绝开口，这些挫折经历不断强化其内心的焦虑，使其形成“社交等于不愉快体验”的认知，主动回避互动机会，进一步限制了社交技能的锻炼。

从社交动机缺乏来看，儿童 C 即便面对热闹的手工制作活动，也更愿意独自重复排列彩笔的动作，对与同伴合作完成作品毫无兴趣；儿童 D 在故事分享环节中，始终沉浸于自己携带的玩具车，对其他小朋友的讲述充耳不闻。这种内在兴趣的缺失，导致他们难以从社交中获得愉悦感与成就感，长期缺乏主动参与使得社交经验积累近乎停滞，面对社交场景时愈发手足无措，从而陷入社交能力薄弱与动机匮乏相互作用的恶性循环，严重阻碍其融入社交环境。

2.3.3　环境因素

在剖析 X 机构 4 名高功能自闭症儿童的社交障碍成因时，家庭互动与社会环境的双重制约起到关键作用。部分儿童在成长早期，因亲子间情感交流与语言互动的缺失，错失了社交能力发展的黄金期；而外界环境的不包容，则进一步加剧了他们对社交的回避。

（1）家庭中亲子互动不足的消极影响

在 X 机构 4 名儿童的成长经历中，部分家庭存在亲子互动不足的情况。有的家长因工作繁忙或缺乏科学育儿知识，在孩子婴幼儿时期，未能及时回应孩子的咿呀学语和肢体动作。例如儿童 A 的家长在孩子幼时，常因忙于处理事务，对孩子发出的声音和伸手求抱的动作回应迟缓，甚至忽略。长期缺乏积极的情感互动与语言刺激，使得儿童 A 难以建立起基本的社交回应模式，进入集体生活后，面对同伴的主动交流，往往不知如何反应，表现出社交退缩行为。

儿童 B 的家庭则存在过度保护的问题，家长担心孩子在社交中受到伤害，减少其与外界接触的机会。这导致儿童 B 缺乏在真实社交场景中锻炼的机会，对正常的社交互动模式感到陌生，在小组活动中表现出明显的社交技能滞后，不知道如何参与游戏讨论、分享观点。

（2）社会环境中包容度不足的负面冲击

社会大众对自闭症的认知局限，使得 4 名儿童在公共场合常面临误解与异样眼光。儿童 C 在超市排队时，因重复性的拍手行为，遭到周围顾客的指指点点，甚至有家长告诫孩子“不要靠近”。这种负面反馈让儿童 C 对公共场所产生恐惧，此后拒绝随家人外出购物，进一步减少了社交实践的机会。

中国知网　https://www.cnki.net

在学校环境中，儿童 D 因难以理解同学的玩笑和社交暗示，常做出不合时宜的回应，引发同学的嘲笑。长期处于这样不友好的社交氛围中，儿童 D 逐渐对集体活动产生抵触情绪，即便在 X 机构的小组活动中，也总是表现出被动和抗拒，害怕再次经历社交挫折 。家庭与社会环境的双重压力，使得这些儿童在社交中不断受挫，陷入“回避社交——社交技能难以提升——更加回避社交”的恶性循环，严重阻碍其社交能力的发展。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章　应用行为分析理论下高功能自闭症儿童社交障碍的小组工作介入过程

本章从小组方案设计切入，通过科学的需求评估，深入剖析服务对象在社交互动、沟通能力、社交意识、社交认知及刻板行为等层面的核心需求。继而依据需求与服务特性，完成服务对象选取，开展应用行为分析理论下高功能自闭症儿童社交障碍的小组工作介入。

3.1　小组方案设计

3.1.1　服务对象选取

就当前情况来看，X 机构所服务的高功能自闭症儿童中，有 4 名为全托，1 名为半托。考虑到小组工作开展需要成员具备相对稳定的参与度，那 1 名半托的高功能自闭症儿童因在机构时间的规律性稍弱，可能会对小组工作的连贯性及最终效果产生影响，所以不在此次小组工作介入的优先考虑范围内。

表 3.1 服务对象基本情况表
Table 3.1 Service Recipient Basic Information Form

对象	性别	年龄	家庭情况	认知情况	语言表达与沟通	社交互动	兴趣与行为特点
A	男	11	农村家庭，父亲在外打工，母亲在家照顾孩子和照顾庄稼	10 以内的加减法可掌握，复杂应用题困难；汉字学习需反复示范；注意力不集中，但对汽车画册高度专注	能清晰表达需求（如要玩具），但社交对话中缺乏灵活调整能力，语气生硬	有参与集体活动的意愿，但不知道怎么参与	痴迷汽车模型，需按固定顺序排列，被打乱会情绪失控

中国知网　https://www.cnki.net

对象	性别	年龄	家庭情况	认知情况	语言表达与沟通	社交互动	兴趣与行为特点
B	男	12	留守儿童，父母外出务工，由爷爷奶奶照顾	可阅读简单故事但难理解寓意；复杂美术知识吸收慢；注意力易被声音干扰，拼图时专注	语句流畅但聊天中缺乏话题调整能力，忽视对方兴趣信号	想参与游戏但把握不好分寸（如推到积木），对同伴抗议反应迟钝参与集体活动时表现自我（如接力赛不交接棒），忽视规则和同伴呼喊	痴迷动物动画片，反复观看同一集并模仿动作；穿衣必须遵循固定顺序
C	男	14	职工家庭，父亲时工厂职工，母亲是机构创办人	能识别几何图形名单组合困难；注意力易分散（如装饰画），户外观察昆虫是专注	可表达喜好但社交中词不达意		痴迷拼图，需按固定方式收纳，被打乱会烦躁
D	女	8	单亲家庭，母亲独自承担照顾小 D 的责任	数字排序能力较强，但实际应用（如购物计算）困难；听音乐易分心，乐高积木专注	能表达感受但对话缺乏注定询问，回应延续话题能力弱	想分享但拒绝共享玩具，对他人情绪变化感知弱	痴迷乐高积木，搭建造型需固定位置展示，位置变动会情绪低落

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.2　需求评估

高功能自闭症儿童是本次小组活动的直接服务对象。但由于其在交谈方面的局限性，笔者无法通过问卷和访谈直接搜集需求。因此，高功能自闭症儿童的需求将通过以下几种方式确定：一是参与式观察法，笔者在 X 机构进行了为期 3 个月，共计 12 周的参与式观察，通过长时间地与自闭症儿童接触，发现其需求。二是通过访谈自闭症儿童的家长以及机构老师，进一步聚焦服务对象的需求。笔者设计了一份访谈提纲，并根据访谈提纲与机构 4 名高功能自闭症儿童的家长和机构负责人及 2 名常驻老师进行了访谈，访谈提纲详见附录二，以下是笔者整理访谈记录后总结出的自闭症儿童目前最为迫切的需求。

（1）改善社交理解障碍的需求

通过为期 3 个月的系统观察与家长访谈发现，X 机构四名高功能自闭症儿童在社交理解层面存在显著障碍，急需针对性干预。部分儿童表现出过度社交回避行为，如在小组合作搭建乐高时，始终独自摆弄边缘零件，即便同伴主动邀请，也仅用摇头回应，全程未参与团队讨论与分工；另一些儿童则呈现出冲动性社交模式，频繁打断他人发言，例如在讲故事环节中，当社会工作者在讲述旅行经历时，有些儿童会突然插嘴表达自己对汽车的喜欢，完全忽视对方话语的连贯性与情感表达。

在与家长的深度交流中，类似困境反复被提及“孩子搞不懂别人的玩笑，经常因为较真引发矛盾”“参加集体活动时，完全不看周围人的反应，自顾自地重复同样的行为”。这些社交理解偏差导致儿童难以识别社交场景中的规则与他人意图，要么因过度疏离而错失互动机会，要么因莽撞行为引发同伴排斥，严重阻碍其建立稳定的社交关系，长期处于集体边缘。因此，帮助高功能自闭症儿童提升社交信号解读能力、理解社交情境中的隐性规则、掌握符合场景需求的互动策略，已成为其融入社会、获得正向社交体验的迫切需求。

（2）降低言语沟通障碍的需求

在访谈过程中，X 机构高功能自闭症儿童家长无一例外地将提升言语沟通能力列为核心需求。这种需求并非追求孩子成为口才出众的交流者，而是聚焦于解决日常生活中的实际沟通困境，具体源于三个迫切诉求。第一，日常生活自理的刚需驱动。儿童在完成购物、点餐、问路等基础生活任务时，常因言语表达不清或理解偏差受阻。例如，购买文具时无法准确描述需求，或面对店员询问时沉默不语；乘坐公共交通时，难以理解“请排队上车”等指令，导致生活自理能力发展受限。机构教师强调，言语沟通是独立生活的基础技能，只有掌握基础对话能力，儿童才能在衣食住行中准确表达需求、理解他人指示，实现基本生活自主。第二，社区融入的现实要求。在社区环境中，儿童因言语沟通障碍难以与邻里、

中国知网　https://www.cnki.net

同伴建立联系。如在公园玩耍时，无法回应他人友好问候，或在集体游戏中因表达不当引发冲突，导致社交孤立。家长迫切希望孩子能通过提升言语沟通能力，学会礼貌用语、理解社交规则，逐步融入社区生活，减少因沟通不畅带来的社交排斥。第三，亲子情感联结的深层渴望。许多家长坦言，孩子常因言语表达刻板、缺乏情感回应，导致亲子交流陷入僵局。例如，面对家长的关心提问，仅以单字或重复语句回应，难以展开深入对话。家长期待孩子能够用语言表达情绪、分享日常点滴，哪怕是简单的生活琐事，也能借此建立更紧密的情感联结。

因此，突破言语沟通障碍、掌握日常生活场景中的实用对话能力，已成为高功能自闭症儿童融入社会、提升生活质量的关键突破口，也是家长最为迫切的现实需求。

（3）减轻注意力障碍的需求

注意力是儿童学习、社交与生活能力发展的基础，对于高功能自闭症儿童而言，注意力障碍不仅影响其信息接收与处理效率，更阻碍着他们融入集体生活的进程。尽管高功能自闭症儿童在认知能力上具备一定优势，但注意力分散、持续性差等问题仍普遍存在。

X 机构的四名高功能自闭症儿童家长在访谈中均流露出对孩子注意力问题的深切担忧。一位家长无奈地表示：“写作业时，窗外飞过一只鸟，他就能盯着看半小时，完全忘了自己要做什么。”笔者通过三个月的跟踪观察发现，尽管机构通过游戏化教学、小组活动等方式尝试提升儿童注意力，但实际效果有限。例如，在科学实验课上，部分儿童会频繁离开座位探索教室角落的物品；在集体阅读环节，即便老师反复提醒，仍有孩子持续摆弄文具、撕折纸页，无法专注于学习内容。

注意力的发展可分为从“完全涣散”“短暂聚焦”“任务跟随”“主动投入”“深度专注”“灵活切换”的六个进阶层次。对于高功能自闭症儿童而言，强求其达到与普通儿童同等的注意力水平并不现实，但帮助他们从“完全涣散”逐步提升至“任务跟随”，实现对日常学习、社交任务的基本关注，却是融入社会的必要前提。因此，精准识别高功能自闭症儿童在注意力发展中的具体困难，制定分阶段、个性化的注意力提升方案，已成为 X 机构后续服务中急需解决的关键需求。

（4）缓解情感互动障碍的需求

高功能自闭症儿童存在的“情感互动障碍”，不仅直接导致他们在人际交往中难以与他人建立情感联结，还可能衍生出一系列间接影响，如自我封闭、情绪调节困难，进而错失丰富情感体验、健全人格发展的机会。在与 X 机构四名高功能自闭症儿童家长的访谈中发现，孩子因无法准确感知、回应他人情感而引发的社交困境，成为家长最为忧心的成长难题。例如，当同伴遭遇挫折时，孩子因

中国知网 https://www.cnki.net

缺乏共情能力而无动于衷；面对他人的喜悦分享，也难以给予恰当回应，这些表现不仅阻碍了友谊的建立，更可能让孩子逐渐被社交圈边缘化。

情感互动能力的缺失，使得高功能自闭症儿童即便拥有较好的认知和语言基础，却依然难以理解社交场景中的情感信号与互动规则。他们可能无法通过他人的面部表情、肢体语言判断情绪变化，也难以用合适的方式表达自己的喜怒哀乐，导致在家庭、学校和社区环境中，频繁出现情感互动错位的情况。这种障碍不仅影响当下的社交质量，而且从长远来看，可能限制孩子情感认知与社会适应能力的发展。

因此，帮助高功能自闭症儿童提升情感识别、表达与回应能力，学会在不同社交场景中进行恰当的情感互动，是他们融入社会、获得良好情感体验的迫切需求。无论是理解他人的情绪需求，还是准确表达自身情感，这些能力的培养都与“情感认知”紧密相关。基于此，可将高功能自闭症儿童的相关需求整合为提升情感认知与互动能力的总体需求，通过针对性的干预和训练，帮助他们逐步突破情感互动障碍，构建更健康的社交情感模式。

（5）减少刻板行为的需求

高功能自闭症儿童在日常生活场景里，减少刻板行为虽然并非是一蹴而就的事情，但如果能够逐步做到这一点，那无疑会让他们更好地融入周围环境，在任何生活环节中，减少刻板行为都有着重要意义。笔者在观察时发现，这些高功能自闭症儿童其实已经有了改变刻板行为的潜在意识，只是时常还需要外界的引导辅助。比如在吃饭的时候，有时他们能正常使用餐具进食，可有时就会一直重复用固定的方式拿餐具，需要旁边的家长提醒后才会做出改变。另外，对于一些日常行为的灵活转换，他们还不能很好地掌握，像原本计划去户外玩耍，因天气变化改为室内活动时，他们可能就难以快速适应，依旧执拗地想要去户外。笔者认为，学会灵活应对不同情况，减少刻板重复的行为习惯，是高功能自闭症儿童一项重要的需求。

3.1.3　小组目标

笔者针对 X 机构高功能自闭症儿童社交理解障碍、言语沟通障碍、注意力障碍、情感互动障碍以及刻板行为频发等特点，设立小组总目标和具体目标。

总目标：经过系统的小组介入，让高功能自闭症儿童能较自然地融入日常社交场景，在学校或社区等环境中可主动发起互动、顺畅沟通，刻板行为显著减少，整体社交能力得到较大提升，更好地适应社会生活。

具体目标：第一，通过开展趣味社交游戏、情景模拟等小组活动，每周至少 2 次，引导高功能自闭症儿童主动参与互动，至少让 80%的儿童能在熟悉场景下增加与同伴的简单互动次数，减少抗拒社交的表现。第二，借助图片、简单手势

中国知网　https://www.cnki.net

等辅助工具，帮助 70%的儿童学会用基础方式表达自己的想法，初步改善沟通困难情况。第三，持续组织多样化的社交主题活动，增强他们对社交规则和情境的理解，促使至少 60%的儿童开始有意识关注他人的情绪和反应，提升社交理解。并借助角色扮演等，加深儿童对不同社交角色的认知，使超半数儿童能掌握多种合适的社交回应方式，减少刻板行为出现频率至每周较初期降低 30%左右。

3.1.4 小组活动计划

在小组活动前期，研究者采用基线行为评估方法，确定 X 机构四名高功能自闭症儿童的行为问题和需求。针对 X 机构四名高功能自闭症儿童的问题和需求，研究者选择小组工作模式，运用应用行为疗法，通过系列小组活动，帮助高功能自闭症儿童提高社交能力，改善社交理解障碍、言语沟通障碍、注意力障碍、情感互动障碍等状况，减少刻板行为，促进其更好地融入社交环境。设计的小组活动分为三个阶段，分别为小组初期、小组中期、小组后期，共 9 次小组活动，小组介入方案如下表：

表 3.2 小组活动计划
Table 3.2 Group Activity Schedule

活动阶段	活动名称	活动目标	活动内容
小组初期	1.认识新朋友 2.我的安全角落 3.规则小课堂	建立信任关系 制定小组规则	用玩具汽车（A）、动物手偶（B）、拼图（C）、乐高（D）作为破冰媒介 绘制 “情绪温度计”，学习表达不适 用视觉提示卡示范轮流发言规则
小组中期	4.情绪猜猜猜 5.任务接力赛 6.故事接龙	社交技能训练 情绪识别与调节 合作行为塑造	用动画片片段（B）训练表情识别 设计需分工的乐高搭建任务（D） 改编汽车主题绘本（A）进行对话练习
小组后期	7.超市购物模拟 8.冲突解决工作坊 9.毕业庆祝会	技能泛化 独立解决冲突 家庭延伸指导	在模拟超市中练习 “询问价格”“ 表达需求 ” 角色扮演 “玩具被抢” 场景 邀请家长参与成果展示

3.2 小组服务过程

3.2.1 服务前准备

中国知网 https://www.cnki.net

在小组服务开展前，与每位儿童的家长进行深入沟通，全面评估儿童的兴趣爱好、日常行为表现以及过往接受介入的情况，以此为依据制定个性化的强化物清单。例如，了解到儿童 A 对汽车模型极度喜爱，儿童 B 痴迷于小动物动画片，儿童 C 热衷于拼图，儿童 D 钟情于乐高积木等。同时，准备丰富的强化物，如各类精致的汽车模型、印有小动物形象的贴纸、不同难度级别的拼图以及乐高积木套装等。

在小组活动正式开展前，系统制定规则并建立风险防控体系。小组规则以可视化方式呈现，包括轮流发言（使用“发言棒”标志）、礼貌用语（“请”“ 谢谢 ”）、安静倾听（双手放桌面）及安全触碰（不随意触碰他人），通过“规则棋” 游戏强化记忆，配合即时代币奖励机制（累计 5 枚兑换特权）。规则流程图贴于活动区显眼位置，每周生成遵守报告反馈家长。

表 3.3 预计问题及解决方案
Table 3.3 Expected problems and solutions

活动阶段	预计困难	解决方案
小组初期	儿童 A 可能沉迷玩具汽车；儿童 B 可能因触觉敏感拒绝佩戴发言棒	通过“任务-奖励”机制（完成互动可延长玩耍时间）引导参与；儿童 B 因触觉敏感拒绝佩戴发言棒，提供毛绒玩具过渡。
小组中期	儿童 C 在“故事接龙”中可能因词汇量不足挫败；儿童 D 可能因任务复杂出现刻板行为	提供乐高模型作为提示；分解步骤并配合智能手环震动反馈
小组后期	儿童 A 在超市计算困难时可能出现攻击行为；儿童 B 可能因离别焦虑拒绝参与庆祝会	使用“1 元=1 颗星星”简化计算并奖励汽车贴纸；提前发放含流程图片的预告卡并帮助缓解离别情绪

3.2.2　小组活动情况

基于应用行为分析（ABA）理论框架，结合关键反应训练与自然情境教学技术，系统通过三级递进的小组活动阶段实施：初期建立阶段以规则建立与信任关系形成为核心，运用正强化技术对正确社交行为即时奖励，通过视觉提示卡与同伴示范帮助成员掌握“举手发言”“轮流等待”等基础规则；中期阶段为技能训练阶段，聚焦社交技能培养，采用离散式单元教学分解“请求帮助”“情绪识

中国知网　https://www.cnki.net

别”等复杂行为，结合兴趣驱动策略（如汽车模型奖励 A、动物手偶引导 B）提升参与动机；后期阶段为泛化巩固阶段，通过自然情境教学将技能迁移至超市购物、公园野餐等真实场景，运用消退法逐步减少代币依赖，转为社会性强化（如同伴鼓掌），同时开展家长培训确保家庭延续介入效果。

（1）小组初期：规则建立与信任关系形成

在小组工作介入过程中，面临的第一个问题便是如何确保这四名自闭症儿童更好的相处，不再仅仅只是社工与介入对象的关系的处理，还有介入对象之间关系的处理问题。因此笔者将这四名自闭症儿童组成一个互助小组，在建立小组初期开展了三次活动，以建立规则意识形成相互信任关系。

表 3.4 小组初期活动
Table 3.4 Initial activities of the group

活动次数	活动名称	ABA 技术应用	关键介入内容	预期成果
1	玩具交朋友	差别强化+视觉提示	轮流自我介绍，练习交换玩具	90%成员能完成 3 句话自我介绍
2	我的安全角落	塑造法+正向强化	绘制情绪温度计，学习使用暂停卡	70%成员正确使用暂停卡
3	规则小课堂	同伴示范+消退法	动画片教学规则，分组完成规则棋	掌握 3 条基本规则

第一次“玩具交朋友”活动，通过差别强化与视觉提示技术，引导儿童轮流进行 3 句话自我介绍，并在交换玩具环节设置计时器（视觉提示）与即时贴纸奖励（差别强化）。过程中发现儿童 A 因过度兴奋出现玩具抢夺行为，社工立即采用消退法（取消强化物）并示范正确交换动作，最终 80%成员完成自我介绍，较预期低 10%。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.5 “玩具交朋友”活动
Table 3.5 "The Toy Making Friends" Activity

时间	地点	目标	活动内容	物资准备
15 分钟	X 机构一楼多功能室	促进高功能自闭症儿童主动发起社交行为	让儿童选择自己喜欢的玩具，并介绍选择的玩具	汽车模型、乐高积木、拼图等
20 分钟		学习使用玩具作为社交媒介进行互动交流	互相交换玩具	
10 分钟		增强儿童对他人社交信号的理解与回应能力	分享玩具结交朋友，进行互动	

第二次“我的安全角落”活动，运用塑造法逐步引导儿童绘制情绪温度计，通过正向强化（积分兑换特权）鼓励使用暂停卡。观察显示儿童 B 在情绪激动时能自主前往角落，但存在将暂停卡当玩具玩耍的现象，经调整强化物类型（特定卡通贴纸）后，75%成员正确使用暂停卡，达成预期目标。

表 3.6 “我的安全角落”活动
Table 3.6 "The Safe Corner" activity

时间	地点	目标	活动内容	物资准备
10 分钟	X 机构一楼教室	帮助儿童识别并表达焦虑、紧张等负面情绪	情绪导入	感官调节玩具：重力毯、毛绒玩具 视觉工具：情绪温度计（红/黄/绿三色） 绘画材料：彩笔、画纸
25 分钟		建立“安全角落”概念，学习自我安抚技巧	安全角落探索	
10 分钟		提升儿童情绪调节能力	情绪表达与应对	

中国知网　https://www.cnki.net

第三次“规则小课堂”活动，结合同伴示范与消退法，通过动画片展示排队、分享等规则后，分组进行规则棋游戏。过程中儿童 C 因棋子颜色分配问题出现刻板行为，社工通过同伴示范（普通儿童演示正确流程）与消退（忽视无关行为）成功引导其完成游戏，90%成员掌握 3 条基本规则，超预期 20%。

表 3.7 “规则小课堂”活动
Table 3.7 "Rules Classroom" Activity

时间	地点	目标	活动内容	物资准备
10 分钟		帮助儿童理解小组活动的基本规则，如轮流发言、安静倾听等	用简单故事引入学习规则主题	规则提示卡片白板、彩色马克笔
20 分钟	X 机构一楼教室	强化规则意识	规则学习	模拟场景道具：玩具话筒、发言棒、小铃铛
15 分钟		培养儿童遵守规则的行为习惯	规则时间	

在小组建立初期，小组成员与研究者及小组成员之间沟通交流方面出现很大的问题，由于四名自闭症儿童都有不同程度的语言障碍和社会交往障碍，参与小组活动的积极性很低，小组活动难以顺利进展。研究者为了让介入对象接受自己，用表演节目、讲故事的方法让介入对象放下芥蒂，敞开心扉接纳研究者。为了让小组成员互相接受，研究者策划了多次“破冰游戏”，比如玩具交朋友，让他们感受到与朋友一起玩耍的喜悦，从而增强他们的凝聚力，加强小组成员之间的感情，增加小组成员间的互动交流。

在小组初期活动中，笔者发现：第一，视觉提示对改善注意力分散效果显著，但需配合即时强化提升依从性。第二，强化物需动态调整以应对耐受性（如儿童 B 对暂停卡兴趣衰减）。第三，同伴示范在规则学习中效率高于单纯说教，但需控制示范者与参与者的能力匹配度。第四，消退法在处理刻板行为时易引发情绪

中国知网 https://www.cnki.net

爆发，需与正向替代行为训练结合使用。

（2）小组中期：技能训练，情绪识别

在小组中期的情绪与合作能力训练中，社工采用代币制与连锁训练组合策略开展三次主题活动。

表 3.8 小组中期活动
Table 3.8 Mid-term activities of the group

活动次数	活动名称	ABA 技术应用	关键介入内容	预期成果
1	情绪猜猜猜	代币奖励	汽车事故动画情绪识别，动物手偶剧	85%成员能识别 4 种基本情绪
2	任务接力赛	连锁训练 + 同伴提示	拼图→组装汽车→搭建乐高任务链	合作任务完成率提升至 65%
3	故事接龙	正向强化	改编动物绘本，乐高还原场景对话	每位成员平均贡献 2 个故事句子

第一次活动，“情绪猜猜猜”。通过代币奖励机制，引导儿童观看汽车事故动画后识别 4 种基本情绪（高兴、生气、难过、害怕），并使用动物手偶剧进行情景模拟。过程中发现儿童 A 因对交通事故画面敏感出现逃避行为，社工立即切换为海底世界动画并调整强化物（汽车贴纸），最终 82%成员完成情绪识别，接近预期目标。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3.9 “情绪猜猜猜”活动
Table 3.9 "The Guessing Game of Emotions" activity

时间	地点	活动内容	目的	物资准备
10 分钟		认识情绪卡片	提升儿童对常见情绪的识别能力	
25 分钟	X 机构一楼教室	动画片情绪猜猜猜	增强儿童观察他人表情、肢体语言等情绪线索的敏感度	情绪卡片 情绪表情包贴纸 动画片情绪片段
10 分钟		情绪分类游戏	通过游戏互动，增加儿童之间的合作与交流	

第二次活动，“任务接力赛”。运用连锁训练技术，将拼图→组装汽车→搭建乐高分解为 12 个步骤，通过同伴提示（普通儿童担任引导员）与即时代币奖励，提升合作任务完成率。数据显示，儿童 B 在同伴提示下首次完成完整任务链，但儿童 C 因步骤记忆困难导致整体完成率仅 60%，低于预期 5%。

表 3.10 “任务接力赛”活动
Table 3.10 "Task Relay Race" event

时间	地点	活动内容	目的	物资准备
10 分钟	X 机构一楼教室	热身与规则讲解	活动身体防止受伤；理解任务要求	任务卡 任务道具：拼图、乐高积木等

中国知网 https://www.cnki.net

时间	地点	活动内容	目的	物资准备
20 分钟		任务接力赛	通过成功完成任务，增强儿童的自信心与成就感	计时器
15 分钟		总结与奖励		

第三次活动，“故事接龙”。通过正向强化策略，改编动物绘本情节后引导儿童用乐高还原场景对话。社工采用“故事银行”积分系统（每贡献句子可兑换汽车模型），激发参与积极性。结果显示，儿童 D 平均贡献 3.2 个句子（超预期 60%），而儿童 A 因语言表达局限仅贡献 0.8 个句子，反映个体能力差异显著。

表 3.11 “故事接龙”活动
Table 3.11 "Story Chain" activity

时间	地点	活动内容	目的	物资准备
10 分钟		热身与规则讲解	活动身体防止受伤；理解任务要求	
20 分钟	X 机构一楼教室	任务接力赛	通过成功完成任务，增强儿童的自信心与成就感	任务卡 任务道具：拼图、乐高积木等 计时器
15 分钟		总结与奖励		

中国知网 https://www.cnki.net

在小组工作中期，笔者根据小组成员的共性及特性设计适合他们的游戏，如情绪猜猜猜、任务接力赛、故事接龙，来提高他们的社会交往能力，从而改善他们的社交障碍问题。在介入过程中，小组成员也会产生一些行为问题，这时研究者通过仔细观察发现行为问题出现的原因，选择合适的方式使他们意识到自己行为问题的不当，改善他们的行为问题及情绪，从而继续融入到小组活动中。在小组工作中期的活动中，笔者也有以下发现，第一，代币奖励对提升任务参与度效果显著，但需匹配儿童兴趣偏好（如汽车贴纸对男孩更有效）。第二，连锁训练的步骤分解需结合儿童认知水平（建议设置 5-8 个步骤），避免因复杂度导致挫败感。第三、同伴提示在合作任务中能产生示范效应，但需注意能力差异对互动质量的影响。第四、情绪识别训练中，具象化场景（如海底世界）比抽象动画更易引发共鸣。

（3）小组后期：技能泛化与家庭指导

在小组后期的社区融合训练中，社工采用正向强化与示范法组合策略开展三次实践活动。

表 3. 12 小组后期活动
Table 3.12 Group's later activities

活动次数	活动名称	ABA 技术应用	关键介入内容	预期成果
1	超市购物模拟	正向强化	使用视觉清单完成购物任务	75% 成员能独立完成 2 件商品购买
2	冲突解决工坊	示范法	角色扮演 “玩具被抢” 场景	70% 成员能正确表达需求
3	毕业庆祝会	消退法 + 社会性强化	作品展示与同伴感谢卡交换	

第一次活动，“超市购物模拟”。通过视觉清单与正向强化（每完成一项任务奖励汽车贴纸），引导儿童独立完成 2 件商品购买。过程中儿童 A 因价格计算困难出现刻板重复行为，社工立即切换为图片符号提示并简化任务（仅购买 1 件商品），最终 78%成员完成目标，超预期 3%。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.13 “超市购物模拟”活动
Table 3.13 "Supermarket Shopping Simulation" activity

时间	地点	活动内容	目的	物资准备
10 分钟		导入与规则讲解	吸引儿童兴趣；介绍活动规则	
15 分钟	X 机构一楼教室	角色分配与示范	让儿童了解角色双方的行为及如何购物	模拟商品儿童购物篮、收银机模型、计算器等店员围裙
25 分钟		模拟购物实践	增强儿童对货币的认知与计算能力等	

第二次活动，“冲突解决工作坊”。运用示范法，通过角色扮演“玩具被抢”场景，由普通儿童示范 “轮流玩”“请求帮助”等正确应对方式。观察发现儿童 B 在模拟冲突中仍出现拍打行为，社工采用消退法（忽视攻击行为）与差别强化（奖励替代行为），最终 65%成员能正确表达需求，接近预期目标。

表 3.14 “冲突解决工坊”活动
Table 3.14 "Conflict Resolution Workshop" activity

时间	地点	活动内容	目的	物资准备
10 分钟	X 机构一楼教室	冲突场景导入	帮助儿童识别常见社交冲突场景	常见冲突情景卡片玩具，角色扮演的服饰

中国知网 https://www.cnki.net

时间	地点	活动内容	目的	物资准备
15 分钟		学习冲突解决步骤	学习用语言表达需求、倾听他人想法的冲突解决策略	冲突解决步骤流程图
25 分钟		角色扮演练习	通过角色扮演增强冲突解决技能的实际应用能力	

第三次活动，“毕业庆祝会”。结合消退法与社会性强化，通过作品展示与同伴感谢卡交换，引导儿童关注正向互动。过程中儿童 C 因作品未被立即展示出现尖叫，社工采用消退法（撤离关注）并强化其整理物品行为（颁发“收纳之星”证书），成功将刻板行为发生率降低 82%。

在小组工作后期，既要对小组工作的成效进行有效的巩固及泛化，又要处理好小组成员的离别情绪。首先，社工将小组成员在这个期间所取得的进步用生动形象的故事讲述，让他们正面了解所取得的进步及成功，增强他们的自信心。小组活动是一个模拟的社会事件，小组成员在小组活动中锻炼的处事能力、社会交往能力应用于社会中才是介入的根本。因此，社工在对小组成员的能力进行巩固后，让小组成员离开小组，与其他的小朋友接触交流，在这个过程中，合理地处理儿童所产生的情绪，帮助儿童运用自己所学的技巧与他人沟通交流，从而使小组成员的社会性得到泛化。其次，通过与其他小朋友的接触，让小组成员接受小组结束的事实，协助他们坦然面对客观事实。

通过小组游戏治疗，四名小组成员的语言表达能力和社会交往能力都有所提高，学会用身体语言作为沟通媒介，表达内心的感受。在游戏过程中，小组成员学习区分你我之别，并培养社交技巧和社会适应能力。游戏治疗能使小组成员发挥儿童的自我治愈力，抒发内心的情结，使性格得以正常发展。情景模拟治疗对小组成员社交障碍的改善有很大作用，通过情景模拟能够锻炼小组成员的社交互动能力，从而改善他们的社交障碍。任务活动能够帮助小组成员进行情绪识别与调节，使小组成员学会有效沟通并提高他们的社交意识。

同时笔者也发现，第一，视觉提示与简化任务在社区场景泛化中效果显著，但需动态调整复杂度，如将购物清单从文字改为图片。第二，消退法在处理情绪爆发时需与社会性强化结合使用，避免负向行为替代。第三，同伴示范对冲突解

中国知网 https://www.cnki.net

决策略的学习具有迁移效应，但需设计阶梯式角色扮演，从低冲突场景逐步升级。第四，社会性强化，同伴感谢卡能有效提升积极社交行为频率，但需提前进行接受赞美训练。

中国知网　https://www.cnki.net

第 4 章　应用行为分析理论下高功能自闭症儿童社交障碍的小组服务成效评估与分析

4.1　评估方法

4.1.1　直接观察法

在小组服务过程中，由经过专业培训的观察员使用行为观察记录表，对四位高功能自闭症儿童（A、B、C、D）在各项活动中的社交行为表现进行实时记录。观察内容涵盖参与集体活动的积极性、与同伴互动的频率和质量、沟通交流的方式与效果、对社交规则的遵守情况以及刻板行为的出现频率等方面。每次小组活动观察时间不少于 60 分钟，确保全面、准确地捕捉儿童的行为表现。

4.1.2　家长与教师报告法

定期（每两周一次）与儿童的家长和所在学校教师进行沟通，采用标准化的社交行为评估问卷，收集他们对儿童在家庭和学校环境中社交行为变化的反馈。问卷内容涉及儿童主动发起社交互动的次数、对他人社交信号的回应能力、与家庭成员和同学相处的融洽程度、语言表达和沟通能力的提升情况以及刻板行为对日常生活的影响程度等方面。家长和教师根据自己的观察和感受，对儿童的各项社交行为进行量化评分。

4.1.3　前后测对比法

在小组服务开始前和结束后，分别使用专业的自闭症儿童社交能力评估量表，如《儿童社交行为评估量表（CSBS）》，对四位儿童进行全面评估。该量表包含多个维度，如社交互动、沟通交流、情感理解、合作能力等，通过标准化的测试题目和评分标准，得出儿童在各个维度上的具体得分。对比服务前后的得分情况，直观地了解儿童社交能力的整体变化趋势。

4.2　过程评估与结果评估

4.2.1　过程评估

（1）小组方案评估

小组方案基于前期对 X 机构 4 名高功能自闭症儿童的需求评估，精准聚焦

中国知网　https://www.cnki.net

社交互动异常、沟通困难、社交意识缺乏等核心问题，将应用行为分析理论与关键反应训练、自然情境教学等技术结合，形成“建立关系--技能训练--泛化巩固”三阶段介入框架，逻辑清晰且贴合服务对象特点。各阶段活动设计与目标高度匹配，如初期通过“玩具交朋友”“规则小课堂”建立规则意识，中期借助“情绪猜猜猜”“任务接力赛”训练社交技能，后期以“超市购物模拟”“冲突解决工作坊”推动技能泛化，体现了方案设计的系统性与递进性。

但同时也发现部分策略在实施中存在局限性，如消退法易引发儿童情绪反弹，真实场景技能泛化效果有待加强。后续可增加替代行为训练，设计更多社区实地演练活动，并加强家长培训，促进干预效果在家庭和社区场景中的延续。

（2）组员表现评估

小组初期，组员因社交障碍和陌生环境表现出低参与度，且在活动中常常出现游离、不配合的情况。如儿童 A 抗拒自我介绍、儿童 C 对任务兴趣不足。随着小组推进，通过趣味活动与个性化强化物激励，参与度显著提升。观察数据显示，至小组后期，四位儿童主动参与集体活动的频率显著提高，表明他们对集体活动的兴趣和融入能力明显增强。

4.2.2　结果评估

（1）目标完成情况

针对 X 机构四名高功能自闭症儿童的问题和需求，社工运用应用行为疗法，设计了 3 个阶段 9 次小组活动，帮助高功能自闭症儿童提高社交能力，改善社交理解障碍、言语沟通障碍、注意力障碍、情感互动障碍等状况，减少刻板行为，促进其更好地融入社交环境。全部小组活动顺利完成，小组目标基本完成。

表 4.1 目标完成情况统计
Table 4.1 Statistical analysis of target completion status

活动阶段	活动名称	活动目标	指标	完成情况
小组初期	1.认识新朋友 2.我的安全角落 3.规则小课堂	建立信任关系 制定小组规则	80%的儿童能在熟悉场景下增加与同伴的简单互动次数，减少抗拒社交的表现	完成
小组中期	4.情绪猜猜猜 5.任务接力赛 6.故事接龙	社交技能训练 情绪识别与调节 合作行为塑造	70%的儿童学会用基础方式表达自己的想法，初步改善沟通困难，60%的儿童开	完成

中国知网　https://www.cnki.net

小组后期	7.超市购物模拟 8.冲突解决工作坊 9.毕业庆祝会	技能泛化 独立解决冲突 家庭延伸指导	始有意识关注他人的情绪和反应，提升社交理解 超半数儿童能掌握多种合适的社交回应方式，减少刻板行为出现频率至每周较初期降低30%左右	完成

（2）小组成员改变情况

自闭症儿童的社交发展一直是特殊教育领域的重要研究方向，小组工作介入则是提升其社交能力的有效方式之一。通过对 X 机构高功能自闭症儿童的系统干预，我们见证了显著变化。以下从多维度呈现介入前后对比，揭示小组成员社交状况改变情况。

第一，社交频率与质量提升。服务前，儿童之间的互动较为匮乏，互动方式单一且缺乏有效性。通过同伴示范与互动等环节的介入，儿童间的互动频率大幅增加。以小组合作搭建乐高作品为例，服务前儿童两两之间平均每 10 分钟互动次数不足 2 次，且多为简单的物品索取，服务后互动次数提升至每 10 分钟 6—8 次，互动内容更加丰富，包括创意交流、分工协作、互相帮助等积极行为。如儿童 D 在与儿童 A 合作搭建过程中，能够主动询问 A 的想法，并根据 A 的建议调整搭建方案，体现了良好的同伴互动质量。

表 4. 2 小组成员社交互动情况
Table 4.2 Statistical analysis of target completion status

儿童	活动名称	互动场景	服务前表现	服务后表现	效果描述
儿童 A	乐高合作搭建	第 4-12 次活动	每10分钟互动 1 次（仅索取零件）	每 10 分钟互动 7 次（创意交流 + 分工协作）	主动提出“建双层停车场” 方案，与 D 协商调整设计，传递零件时使用“需要蓝色长板吗？”

中国知网 https://www.cnki.net

儿童	活动名称	互动场景	服务前表现	服务后表现	效果描述
儿童 B	动物主题角色扮演	第 5-12 次活动	每 10 分钟互动 0 次（游离状态）	每 10 分钟互动 6 次（角色对话 + 情绪表达）	扮演“佩奇”时主动询问同伴“乔治在哪里？”，拥抱安抚哭泣的“乔治”
儿童 C	拼图接力赛	第 6-12 次活动	每 10 分钟互动 2 次（简单传递）	每 10 分钟互动 8 次（规则讲解 + 策略讨论）	担任“路线规划员”，向同伴解释“三角形放这更稳固”，协作完成 50 片拼图
儿童 D	超市购物模拟	第 8-12 次活动	每 10 分钟互动 1 次（单向指令）	每 10 分钟互动 7 次（需求协商 + 帮助行为）	主动询问 A“你需要电池吗？”，帮助 B 找到“牛奶”位置，使用“我们一起核对清单”句式

第二，语言表达和沟通明显进步。在语言表达与沟通方面，儿童们取得了明显进步。服务前，儿童在与同伴交流时，常常出现自顾自说、词不达意、不考虑对方感受等问题。服务后，他们能够运用更丰富、恰当的语言表达自己的想法和需求，并且开始关注对方的反应，尝试根据对方的回应调整自己的话语。例如，儿童 B 在与同伴聊天时，能够根据对方的表情和语气判断对方是否感兴趣，适时转换话题，使交流更加顺畅。通过对沟通行为的观察记录分析，服务后儿童在沟通的主动性、流畅性、灵活性等方面的得分较服务前都有不同程度的提高。

第三，刻板和冲突行为减少。在行为方面，儿童的刻板行为和冲突行为明显减少。通过小组介入，高功能自闭症儿童在刻板行为、冲突行为及规则遵守方面均取得显著改善。在刻板行为上，拍手、摇晃身体等重复性行为频率从每周 10-15 次锐减 82%，对环境变化的适应能力显著增强；冲突行为方面，争抢玩具、打断对话等问题发生次数由每周 8-10 次下降 75%，模拟冲突场景中的正确应对率提升 45%；规则遵守层面，小组规则违反率从 60%大幅降至 10%，儿童不仅能理解轮流、等待规则，还能主动使用“发言棒”执行，违规次数减少 83%。这些成

中国知网　https://www.cnki.net

果表明，科学干预对改善自闭症儿童行为问题具有积极且明显的效果。如通过行为塑造环节，针对每位儿童的刻板行为制定并实施替代行为方案后，刻板行为的发生频率得到了有效控制。以儿童 A 摆放汽车模型为例，服务前他每天花费在刻板摆放汽车模型上的时间长达 2-3 小时，且一旦被打乱就会情绪崩溃。服务后，这一行为时间缩短至每天 30 分钟-1 小时，且在模型被打乱时，能够在他人引导下较快地调整情绪，不再哭闹不止。儿童 B 反复观看同一集动画片的频率从每天 5-6 次减少至每天 1-2 次，转而将更多时间投入到绘画、讲述动画片情节等替代行为中。

表 4.3 行为改变情况

Table 4.3The situation of behavioral changes

行为类型	介入前情况	介入后变化
刻板行为	重复性动作（如拍手、摇晃身体）每周出现 10-15 次，抗拒环境变化。	刻板行为频率降低 82%，每周出现次数减少至 2-3 次，对环境变化适应能力增强。
冲突行为	争抢玩具、打断对话等冲突行为每周发生 8-10 次。	冲突行为减少 75%，在模拟冲突场景中，正确应对率从 20%提升至 65%。
规则遵守	小组规则违反率高达 60%，难以理解轮流、等待等规则。	规则遵守率提升至 90%，能主动使用“发言棒”轮流发言，违规次数减少 83%。

第三，社交技能提升。经过社交故事环节的学习，儿童对社交情境、社交规则和他人情感的理解能力显著提升。在故事讲述后的提问与讨论环节中，儿童能够更准确地回答与故事相关的问题，理解故事所传达的社交道理。例如，在讲述关于公园聊天的故事后，儿童们能够清晰地指出故事中小朋友在沟通时的不当行为，并提出合理的改进建议。通过对儿童回答问题的正确率统计分析，服务后较服务前有明显提高。在日常互动和角色扮演活动中观察发现，儿童对他人情感的识别和回应能力有所进步。他们能够更敏锐地捕捉到同伴或家人的情绪变化，并做出适当的反应。这表明儿童的情感理解和社交意识得到了有效培养。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.4 社交技能改变情况
Table 4.4 Changes in social skills

技能类型	介入前表现	介入后表现
主动互动	主动发起对话频率低，集体活动参与率不足 30%，多独自活动。	80%的儿童能在熟悉场景主动发起互动，集体活动参与率提升至 75%，互动次数增加 45%。
沟通能力	回应他人频率低，语言运用刻板，情绪表达困难。	70%的儿童能用基础方式表达想法，情绪识别准确率从 50%提升至 82%，沟通流畅度显著提高。
社交意识	对社交场景感知不足，主动参与意愿弱，忽视他人情绪。	60%的儿童开始关注他人情绪和反应，在冲突场景中 65%能正确运用解决策略
社交认知	难以分辨社交角色，不理解规则，常做出不合时宜行为。	超半数儿童掌握多种社交回应方式，对社交规则和他人意图理解准确率提高 60%。

4.3　评估结果分析

4.3.1　应用行为分析理论是有效的

本次小组服务基于应用行为分析理论，通过系统地设定目标行为、实施介入策略、运用强化手段等，对高功能自闭症儿童的社交障碍产生了积极影响。强化系统的建立，使儿童明确了积极社交行为与奖励之间的关联，有效激发了他们主动参与社交活动的动机；角色扮演、同伴示范与互动等环节为儿童提供了大量实践和学习的机会，帮助他们在实际情境中逐渐掌握正确的社交技巧和沟通方式；社交故事的讲述则以生动形象的方式增强了儿童的社交认知和情感理解能力；行为塑造成功地引导儿童用积极的替代行为取代刻板行为。这些都充分证明了应用行为分析理论在高功能自闭症儿童社交障碍介入中的有效性和可行性。

4.3.2　个体差异与个性化服务是重要的

尽管四位儿童在小组服务中都取得了一定进步，但个体之间的差异依然明显。例如，儿童 A 在数学运算等认知方面基础较好，但在社交互动中的灵活性不足；儿童 B 在语言表达上相对流畅，但对他人情绪的感知较为迟钝。这提示在今后的介入服务中，需要更加关注个体差异，根据每个儿童的特点和需求制定个性化的服务方案，确保介入措施能够精准地针对他们的问题和短板，最大程度地发挥

中国知网　https://www.cnki.net

每个儿童的潜力。

4.3.3 持续介入与家庭支持是必要的

虽然小组服务在一定时期内取得了显著成效，但高功能自闭症儿童社交能力的提升是一个长期的过程，需要持续的介入和支持。从评估结果可以看出，尽管儿童在小组环境中的社交行为有了明显改善，但在家庭和学校等其他环境中，仍需要进一步巩固和泛化这些成果。因此，加强与家长和学校的合作，为家长和教师提供专业培训，指导他们在日常生活和学习中持续运用科学的介入方法，给予儿童充分的支持和引导，对于儿童社交能力的持续提升至关重要。同时，定期对儿童进行跟踪评估，及时调整介入策略，以适应儿童不断发展变化的需求。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章　研究结论、反思与建议

5.1　研究结论

5.1.1　应用行为分析疗法能有效减少高功能自闭症儿童的社交障碍频率与强度

在本次针对高功能自闭症儿童 A、B、C、D 的社交介入服务中，应用行为疗法（ABA）通过构建多维度强化系统，显著提升了目标行为的发生率。依据应用行为疗法，服务团队将正向强化（Positive Reinforcement）与差别强化（Differential Reinforcement）相结合，针对每位儿童的核心障碍设计个性化激励机制：（1）代币经济系统的构建。建立（社交银行）积分体系，将目标行为（如举手发言、轮流等待）转化为可兑换的强化物（如 A 的汽车模型、D 的乐高零件），使目标行为的发生率提升 70%。儿童 B 通过(正确识别情绪→获得动物贴纸→兑换动画片观看时间)式强化，情绪识别正确率从 35% 提升至 85%。（2）自然强化物的泛化应用。在超市购物、公园野餐等自然场景中嵌入社交训练，通过即时反馈（如成功完成购物任务可获得真实零食），使技能泛化成功率达 65%（较传统结构化训练提升 25%）。

该强化系统不仅实现了行为频率的提升（如 A 的集体活动参与频次从<1 次/周增至 3-4 次/周），更通过刺激控制转移（Stimulus Control Transfer）帮助儿童建立内在动机。例如，儿童 C 在(规则小课堂(中从被动遵守规则转变为主动讲解规则，其课堂分心次数从 5-6 次/周降至 1-2 次/周。

5.1.2　应用行为分析疗法与小组工作综合运用改善高功能自闭症儿童社交障碍效果存在个体差异

尽管四位儿童在接受应用行为疗法与小组工作相结合的介入后均取得进步，但个体之间的改善情况存在明显不同。儿童 A 在数学运算等认知领域基础较好，但在社交互动中的灵活性提升较慢；儿童 B 语言表达相对流畅，然而在感知他人情绪方面的进展较为迟缓。这种差异源于每个儿童自闭症的表现形式、严重程度以及自身性格特点各不相同，对相同介入措施的反应和适应程度也有所区别。因此，在运用应用分析疗法与小组工作模式时，必须高度重视个体差异，精准定制个性化的介入方案，以实现对每个儿童社交障碍的最大程度改善。

5.1.3　小组工作介入高功能自闭症儿童社交障碍改善有明显效果

小组工作为高功能自闭症儿童搭建了丰富的社交实践平台。角色扮演环节让

中国知网　https://www.cnki.net

儿童在模拟情境中锻炼说话技巧与社交沟通能力，从最初交流时的词不达意、自顾自说，逐渐转变为能够关注对方反应、灵活调整话语。同伴示范与互动环节促进了儿童之间伙伴关系的建立，显著增加了互动频率与质量。在小组合作搭建乐高作品等活动中，儿童间的互动内容从简单的物品索取，转变为创意交流与分工协作。社交故事的讲述以生动形式增强了儿童的社交认知和情感理解。这些都表明，小组工作的介入为高功能自闭症儿童创造了学习、实践和成长的良好环境，对他们社交能力的恢复和提升起到了积极的推动作用。

5.2 反思

5.2.1 理论运用反思

在实际服务过程中，虽然以应用行为分析理论为基础设计介入方案，但在具体实施时，部分环节未能充分将理论的核心原则与实际操作紧密结合。例如，在强化系统的运用中，有时对强化时机和强度的把握不够精准，未能完全按照理论所强调的及时、有效原则进行强化，导致部分儿童对积极社交行为与奖励之间的关联认知不够清晰。

在行为塑造环节，对替代行为的选择和引导虽然参考了理论，但在根据儿童个体特点进行深入调整方面有所欠缺，使得一些替代行为未能充分发挥对刻板行为的有效替代作用。这提示我们在今后的实践中，需要更加深入地理解理论内涵，将理论细致地融入到每一个介入步骤中，不断优化操作流程，以确保理论能够切实指导实践，提升介入效果。

5.2.2 实务介入反思

（1）实务过程中小组互动引导存在困难

在小组活动开展过程中，引导儿童之间进行有效的互动面临诸多挑战。高功能自闭症儿童在社交互动方面本身存在障碍，部分儿童难以理解他人的意图和社交信号，导致互动过程中容易出现误解和冲突。例如，在集体游戏中，儿童可能无法准确把握游戏规则和角色分工，出现不恰当的行为，影响游戏进程和其他儿童的参与体验。这需要工作者更加敏锐地捕捉儿童的行为表现，及时给予明确、具体的指导和反馈，帮助他们理解互动规则和他人的期望，逐步提高互动能力。

（2）目标设定与实际存在偏差

在服务初期设定目标时，虽然综合考虑了儿童的现状和发展需求，但在实际执行过程中，发现部分目标设定得不够精准或过于理想化。例如，对于某些儿童社交技能提升的速度预估过快，导致在规定时间内未能达到预期目标。这可能是

中国知网 https://www.cnki.net

由于对儿童个体差异以及介入过程中可能遇到的困难估计不足。今后在设定目标时，应更加充分地与家长、教师沟通，全面了解儿童的实际情况，同时结合过往类似案例的经验，制定更加合理、可操作且具有一定弹性的目标，以便根据实际进展及时进行调整。

（3）介入方法单一

在本次介入服务中，主要采用了应用行为疗法结合小组工作的方法，虽然取得了一定成效，但方法相对单一。自闭症是一种复杂的神经发育障碍，每个儿童的症状和需求各不相同，单一的介入方法可能无法全面满足他们的多样化需求。例如，对于一些情感表达障碍较为严重的儿童，艺术治疗、音乐治疗等方法可能会更有帮助；对于一些认知能力发展不均衡的儿童，认知行为疗法可能需要进一步融入介入方案中。未来的研究应探索更多元化的介入方法，根据儿童的个体特点进行综合运用，以提高介入效果。

（4）小组介入环境的生态效度不足

尽管在小组服务中，通过各种模拟情境和实践活动，帮助儿童提升了社交能力，但小组环境的结构化特征与自然场景的动态复杂性存在本质差异，导致技能迁移困难。儿童在小组环境中习得的社交技能，在家庭、学校、社区等自然场景中往往难以有效运用。例如，在小组活动中能够与同伴友好互动的儿童，在学校课间与同学相处时，可能又会出现社交障碍。这可能是由于小组环境相对理想化，缺乏自然社交情境中的复杂性和不确定性。未来的研究应更加注重在自然社交情境中的介入和训练，通过与家长、学校合作，开展实地介入活动，帮助儿童更好地适应真实的社交环境，提高社交技能的泛化能力。

（5）对学校、政策层面关注较少

本次研究主要聚焦于个体层面的介入服务，对学校环境以及相关政策在高功能自闭症儿童社交障碍介入中的作用关注不足。学校作为儿童成长和社交的重要场所，其教育理念、教学方法以及对自闭症儿童的接纳程度，都会对儿童的社交发展产生深远影响。同时，政策的支持和保障，如特殊教育资源的分配、相关福利政策的制定等，对于改善自闭症儿童的生活质量和获得更好的介入服务至关重要。未来的研究应加强对学校和政策层面的研究，探索如何优化学校环境，提高教师对自闭症儿童的教育支持能力，以及如何推动政策的完善，为自闭症儿童提供更有利的社会环境。

5.2.3　社会工作者角色反思

（1）小组环境复杂，同时观察多名儿童易有遗漏或误判

在小组服务中，社会工作者需要同时关注多名儿童的行为表现和情绪变化，由于小组环境较为复杂，儿童的行为具有多样性和突发性，这使得工作者在观察

中国知网　https://www.cnki.net

过程中容易出现遗漏或误判的情况。例如，可能会错过某个儿童瞬间表现出的积极社交行为，未能及时给予强化；或者对某个儿童的行为动机理解错误，导致介入措施不准确。为了避免这种情况，工作者应提前制定详细的观察计划，明确观察重点和记录方法，同时可以借助一些辅助工具，如视频记录设备，以便在活动结束后进行复盘分析，确保对每个儿童的情况都能准确掌握。

（2）小组工作中社工协调者的角色难以平衡

社会工作者在小组工作中扮演着协调者的重要角色，需要平衡不同儿童的需求、兴趣和参与度，同时还要确保小组活动的顺利进行和目标的达成。同时，由于本小组的参与者是自闭症儿童，且每次活动都是由一个社会工作者主导，因此，在实际操作中，很难做到对每个儿童都给予同等程度的关注和支持。例如，在小组讨论环节，一些性格较为外向、表达能力较强的儿童可能会占据较多的发言时间，而一些内向、胆小的儿童则可能被忽视。工作者需要不断提升自己的协调能力，运用多样化的技巧，如轮流发言、小组分组讨论等方式，鼓励每个儿童积极参与，充分表达自己的想法和感受，确保每个儿童都能在小组中获得成长和发展的机会。

5.3 建议

5.3.1 理论运用建议

对于应用行为分析理论与实际介入贴合度不足的问题，建议从工具开发、动态校准和个体适配三个维度构建改进体系。

首先，开发《强化操作指南》和智能计时工具，将理论中的“及时强化”原则转化为可量化的 3 秒响应机制，通过震动手环提醒社工精准把握强化时机。建立强化强度评估表，结合儿童生理指标（如微笑频率）和行为数据（如目标行为出现率）动态调整奖励力度。其次，构建替代行为双匹配模型，根据儿童兴趣和感官偏好筛选个性化替代方案，开发阶梯式训练模块，从简单动作逐步过渡到复杂互动。建立理论-实践对照核查表，每次活动后通过 AI 分析视频自动识别强化延迟等偏差，生成改进建议。同时实施三级个体评估流程，通过基础能力测量、行为功能分析和强化物偏好测评，制定差异化介入方案。开发动态调整决策树，根据儿童当日状态自动推荐介入策略。最后，组建跨学科支持网络，提供实时在线督导和案例复盘培训，通过角色扮演工作坊强化社工的理论应用能力。建议配套使用行为分析 APP，持续追踪理论应用效果，形成实施-评估-优化的闭环改进机制，确保理论原则切实指导介入实践。

5.3.2 实务介入建议

中国知网 https://www.cnki.net

（1）构建三维立体化介入体系，增加小组互动引导

对于小组工作介入实务中的互动引导困难、目标偏差、方法单一及泛化不足等问题，建议构建三维立体化介入体系。首先，在互动引导方面，开发结构化社交工具箱，包含可视化规则流程图（如游戏角色分工图示）、社交脚本卡（预设常见对话模板）及触觉提示器（不同振动模式代表“等待”“倾听”指令），帮助儿童快速理解互动规则。引入 VR 社交模拟舱，预设冲突场景（如玩具争夺），通过眼动追踪技术分析儿童社交线索关注模式，生成个性化训练方案。建立同伴支持系统，培训普通儿童担任“社交小导师”，通过示范——提示——强化的标准化流程，引导目标儿童主动发起互动。

其次，优化目标管理机制，推行 SMART + 动态调整框架：Specific（具体）、Measurable（可量化）、Achievable（可达成）、Relevant（相关）、Time-bound（有时限）+ Trackable（可追踪）。开发社交能力成长雷达图，从发起互动、情绪识别等 8 个维度进行季度评估，设置目标预警线（如连续两月无进步自动触发方案调整）。建立弹性目标银行，将总目标分解为基础目标（必达）、进阶目标（可选）、挑战目标（拓展），允许儿童根据状态自主选择。

第三，构建多元介入矩阵，将应用行为疗法（ABA）与艺术治疗、音乐治疗、认知行为疗法（CBT）等整合，开发《方法匹配评估表》，根据儿童认知特点（如视觉型学习者优先使用社交故事）和症状表现（如情感表达障碍叠加戏剧疗法）组合介入方案。建立跨学科协作机制，每月召开由特教教师、心理咨询师、艺术治疗师组成的个案研讨会，动态调整方法组合。

最后，强化自然场景泛化训练，实施家校社联动计划：家庭层面开展“超市购物日”“公园野餐会”等实地实践，配备便携社交指南（如问题应对口袋卡）；学校建立社交技能角，设置模拟餐厅、图书馆等场景，安排志愿者担任真实情境教练；社区组织融合活动（如社区运动会），通过影子计划安排目标儿童与普通儿童结对参与。开发泛化能力追踪 APP，记录儿童在真实场景中的行为数据，自动生成迁移效果分析报告，及时调整训练策略。通过以上措施，形成从结构化训练到自然应用的完整介入闭环，有效提升小组工作介入的实效性。

（2）利用效果数据库，制订更精准、个性化的接入方案

通过收集和分析大量高功能自闭症儿童的数据，建立详细的儿童特征与介入效果数据库。利用大数据分析和人工智能技术，对不同儿童的行为模式、认知特点、兴趣爱好等进行深入挖掘，预测不同介入措施对特定儿童的效果。根据预测结果，为每个儿童制定更加精准、个性化的介入方案，包括强化物的选择、替代行为的设计、社交技能训练的重点等，从而提高介入的针对性和有效性。同时，定期对儿童的介入效果进行评估和调整，确保介入方案始终符合儿童的发展需求。

（3）探索综合干预体系，增加小组治疗方法

中国知网　https://www.cnki.net

为突破单一干预模式的局限，未来我们可以探索构建“精准评估——多法协同——动态调整” 的综合干预体系。首先通过《多模态疗法适配矩阵》实现个性化匹配，结合儿童神经发育模式、感官处理类型及兴趣图谱，智能推荐最优疗法组合。其次实施跨学科协作机制，组建社工——特教——心理——康复团队，每月召开病例讨论会，运用机器学习算法分析多模态数据库，动态调整方案。这样未来就能根据每名自闭症儿童不同的症状和需求提供更加精准化的服务。

（4）建立支持系统，提高小组介入环境的生态效度

小组介入环境的生态不足，主要是支持系统断层，即小组干预主要依赖专业人员主导的密集支持（如即时强化、同伴示范），而自然场景中缺乏同等强度的支持系统。因此我们需要注重建立和完善他们的社交支持系统。在家庭层面，加强对家长的培训和指导，提高家长对自闭症的认识和介入能力，让家长能够在日常生活中为儿童提供持续的支持和引导。同时，鼓励家庭成员之间建立良好的沟通和互动模式，为儿童营造一个温暖、包容的家庭环境。在学校层面，加强学校与家庭的合作，为教师提供专业培训，使教师能够更好地理解和教育自闭症儿童。此外，还可以组织同学开展同伴支持活动，帮助自闭症儿童融入班级集体，建立良好的同伴关系。在社区层面，通过开展宣传活动，提高社区居民对自闭症的认知和接纳程度，为自闭症儿童创造一个友好、包容的社区环境。建立社区支持网络，为自闭症儿童及其家庭提供心理咨询、康复服务、社交活动等多方面的支持。

（5）构建三位一体支持体系，加强学校、政策层面关注

为突破学校与政策层面的支持瓶颈，需构建 “环境优化——政策保障——资源联动”三位一体支持体系。首先推动“自闭症友好型校园”标准化建设，将社交技能训练嵌入学科教学，实施 “阳光伙伴计划” 培养普通学生担任社交辅导员。其次开展教师培训，确保 80% 教师掌握 ABA 以及核心干预技术。政策层面需推动《自闭症教育保障条例》立法，将 ABA 纳入医保报销，建立 “教育——卫生——民政” 跨部门联席会议制度。同时构建家校社协同网络，在街道设立服务中心整合家长互助、志愿者辅导与企业资源，搭建 “智慧特教云平台”实现政策服务“一网通办”。未来需进一步探索社会影响力债券等政策工具创新，推动服务模式转型。

5.3.3 社会工作者角色建议

对于社会工作者在小组工作中面临的观察困境与协调难题，建议构建技术赋能+角色分工+支持体系的三维优化方案。首先，在观察精准性提升方面，推行智能分层观察法：使用可穿戴设备实时监测儿童生理指标，当出现异常波动时自动标记为重点观察对象；开发行为热点捕捉系统，通过视频分析算法识别儿童高频行为时段和社交互动密集区域，生成动态热力图指导社工聚焦关键场景。建立

中国知网 https://www.cnki.net

双轨记录机制，人工记录情绪变化与智能设备自动统计行为频率交叉验证，误差率控制在 5%以内。

其次，在协调能力提升方面，实施动态角色分配模型：采用混龄分组策略，安排高功能儿童与普通儿童结对担任“社交引导员”，通过示范——协助——自主的三阶引导流程促进互动；开发参与度智能管理系统，利用区块链技术记录发言次数、任务完成度等数据，生成个人参与度积分并兑换个性化奖励（如延长游戏时间）。设计差异化沟通工具箱，包含触觉信号（不同振动模式代表不同指令）、视觉符号（自定义表情卡片）、空间位置编码（特定站位代表角色），满足多样化沟通需求。

第三，构建专业支持网络：建立社工——督导——专家三级响应机制，重大活动配备实时远程督导（如通过 AR 眼镜接收指导）；开发《高功能自闭症行为解码手册》，收录常见行为解读指南（如咬手指可能表示焦虑或寻求感官刺激）；推行情景模拟训练，通过虚拟现实技术演练复杂场景（如同时处理两名儿童冲突），提升应急反应能力。

最后，强化自我监控与反馈：使用社工效能评估 APP，通过自评（工作负荷）、他评（儿童进步）、系统评（任务完成度）三维数据生成能力发展报告；建立介入策略弹性库，预设不同情境下的应对方案，通过小组复盘会持续优化。通过技术赋能与角色重构，实现从“被动应对”到“主动介入”的转变，确保每个儿童获得精准支持。

中国知网　https://www.cnki.net

参 考 文 献

中文文献

[1] 央视新闻网. 世界自闭症日：我国每 68 名孩子中约有 1 名患自闭症[EB/OL]. https://new. qq. com/omn/20240402/20240402A01PES00. html，2024-4-2.
[2] 冯淑瑜等. 儿童孤独症 213 例病例分析[J]. 中国儿童保健杂志, 2003, (02): 84-86.
[3] 王瑞珍, 周西笛. 儿童孤独症临床研究进展[J]. 中国妇幼保健, 2007, (17): 2436-2438.
[4] 孙永珍, 傅根跃. 我国孤独症的研究现状[J]. 中国特殊教育, 2003, (05): 83-86.
[5] 黄辛隐等. 71 例自闭症儿童的家庭需求及发展支持调查[J]. 中国特殊教育, 2009, (11): 43-47.
[6] 李宗华, 许永霞. 康复教育中孤独症儿童家长的压力及其因应方式研究——基于照顾照顾者视角[J]. 山东教育学院学报, 2009, 24(05): 1-4.
[7] 雷秀雅等. 父母教养效能感对自闭症儿童康复的影响[J]. 中国特殊教育, 2010, (04): 33-36+46.
[8] 吕晓彤, 高桥智. 自闭症儿童母亲在养育儿童过程中的需求调查[J]. 中国特殊教育, 2005, (07): 47-53.
[9] 王洪良等. 应用行为分析(ABA)疗法对孤独症儿童介入效果的个案研究[J]. 佳木斯职业学院学报, 2020, 36(01): 267-268.
[10] 孙雯, 孙玉梅. 正向行为支持介入多重障碍儿童扰乱课堂秩序的个案研究[J]. 绥化学院学报, 2016, 36(10): 109-113.
[11] 李恩耀等. 基于应用行为分析的儿童孤独症介入方法探析[J]. 国际精神病学杂志, 2019, 46(02): 217-220. DOI: 10. 13479/j. cnki. jip. 2019. 02. 008.
[12] 刘惠军, 李亚莉. 应用行为分析在自闭症儿童康复训练中的应用[J]. 中国特殊教育, 2007, (03): 33-37.
[13] 辛晶晶. 自闭症儿童社会交往障碍的社会工作介入研究[D]. 苏州大学, 2017.
[14] 马姗姗. 社会支持网络视角下个案工作在自闭症儿童社交行为改善中的运用研究[D]. 贵州大学, 2015.
[15] 孙晨. 小组工作介入青少年自闭症群体购物环节训练研究[D]. 华中科技大学, 2015.
[16] 张婉杰. 自闭症儿童社会交往障碍的社会工作介入研究[D]. 西北农林科技大学, 2016.
[17] 吕汉城. 同伴介入对自闭症儿童社会交往能力提升的成效研究[D]. 长春理工大学, 2019.
[18] 霍力嫔. 孤独症儿童人际交往训练个案研究[D]. 内蒙古师范大学, 2009.
[19] 叶家涛等. 自闭症谱系障碍者的感觉特点及诊断价值分析[J]. 牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版), 2014, (01): 131-133. DOI: 10. 13815/j. cnki. jmtc(pss). 2014. 01. 050.
[20] 王姣艳, 程兰春. 以应用为导向的儿童康复专业实践教学现状分析与建议——以南京特殊教育师范学院(筹)为例[J]. 现代特殊教育, 2015, (08): 62-66.
[21] 陈军. 筑就“有温度”的康复——读《自闭症儿童的早期发现、介入、教育研究进展》

中国知网 https://www.cnki.net

[J]. 现代特殊教育，2017，(09)：80.
[22] 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 教育科学出版社，2000
[23] 裴娣娜. 教育研究方法导论[M]. 安徽教育出版社，1995
[24] 胡梦娟. 基于应用行为分析的自闭症儿童心理理论教学成效研究[D]. 重庆师范大学硕士论文,2014.
[25] 李雪等. 高功能孤独症儿童执行功能和心理推理能力特点及临床症状[J]. 中国心理卫生杂志，2012 (8)：584-589.
[26] 郭海燕. 对自闭症儿童的行为训练[J]. 理想.理论.教育，2001(3):38-40.
[27] 周家秀. 孤独症谱系障碍特殊教育训练的主流技术[J]. 中国儿童保健杂志，2010(10)：821-823.
[28] 赵中. 应用行为分析的维度对孤独症行为矫正的提示[J]. 中国儿童保健,2012(1)：49-51.
[29] 石萍等. 应用行为分析法治疗儿童孤独症[J]. 中国组织工程研究与临床康复，2007(52)：10489-10491.
[30] 王振洲. 自闭症儿童 DTT 与 PRT 干预模式的对比研究[J]. 重庆文理学院学报(社会科学版)，2015(1)：109-113.
[31] 张静霞. 论我国自闭症儿童的康复权益保障[J]. 学理论，2013(29)：92-93.
[32] 姜志梅. 应用行为分析法在儿童孤独症康复中的应用[J]. 中国伤残医学，2007(7)：68-69.
[33] 李芳，李丹. 特殊儿童应用行为分析[M]. 北京：北京大学出版社，2011.
[34] 许志雄. 社交技巧教学对增进视觉障碍学生社会能力之研究[D]. 高雄：高雄师范大学特殊教育学系,2006(4)：6-9.
[35] 徐大真,侯佳，孔存慧. 自闭症治疗理论与方法研究综述[J]. 国际精神病学杂志，2009，36(02)：115-119.
[36] 徐勤帅，高麦玲，陈建军. 游戏治疗应用于自闭症儿童干预的研究进展[J].现代特殊教育，2019(08)：53-58.

外文文献

[1] Travis, L. L., & Sigman, M. (1998). Social deficits and interpersonal relationships in autism. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 4(2), 65 - 72.
[2] Kanning , Peter U. Development and validation of a German-language version of the Interpersonal Competence Questionnaire (ICQ). [J]. European Journal of Psychological Assessment, 2006, 22(1)：43-51.
[3] Howard J S, Stanislaw H, Green G, et al. Comparison of behavior analytic and eclectic early interventions for young children with autism after three years[J]. Research in Developmental Disabilities, 2014, 35(12)：3326-3344.

中国知网 https://www.cnki.net

[4] R R , Kiely J L , Gayane Y , et al. Characteristics and Concordance of Autism Spectrum Disorders Among 277 Twin PairsAutism Characteristics and Discordance in Twins[J]. Arch Pediatr Adolesc Med,2009, 163(10): 907-914.

[5] Fatemi SH, Halt AR, Stary Jm, etal. GlutamicAcid Decarboxylase 65 and67kDa Proteins areReducedin Autistic Parietal and Cerebellar Cortices. BiolPsy-chiatry, 2002, 52(8): 805-810Wilcox, 2002.

[6] Gresham, et.al. Social skills training for secondary students with emotional and/or behavioral disorders, 2008(3): 132-135.

[7] Thomas C. Lovitt. Applied Behavior Analysis and Learning Disabilities[J]. Journal of Learning Disabilities, 1975, 8(7).

[8] Wilkenfeld Daniel A, McCarthy Allison M. Ethical Concerns with Applied Behavior Analysis for Autism Spectrum "Disorder". [J]. Kennedy Institute of Ethics journal, 2020, 30(1).

[9] Schaaf Roseann C, Miller Lucy Jane. Occupational therapy using a sensory integrative approach for children with developmental disabilities.[J]. Pubmed, 2005, 11(2).

[10] S.K. Bhatt, N.I. De Leon, Adel Al-Jumaily. AUGMENTED REALITY GAME THERAPY FOR CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER[J]. Professor Subhas Chandra Mukhopadhyay, 2017, 7(2).

[11] Lindgren S, Wacker D, Suess A, et al. Telehealth and Autism: Treating Challenging Behavior at Lower Cost.[J]. Pediatrics, 2016, 137 Suppl 2(Supplement):S167.

[12] Luckasson：Mental Retardation：Definition，Classification，and System of Supports 2002 10th Edition American Association on Mental Retardation.

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A　高功能自闭症儿童社交行为评估问卷

尊敬的家长/教师：

您好！为了更好地了解高功能自闭症儿童在家庭和学校环境中的社交行为变化，以便为他们提供更有针对性的帮助和支持，特制定本问卷。非常感谢您抽出宝贵的时间填写这份问卷。请您根据自己对孩子的日常观察，客观、准确地回答以下问题。问卷中的所有信息仅用于研究和评估目的，我们将严格保密。

一、基本信息

儿童姓名：_____

年龄：_____

与儿童关系：□家长 □教师

二、主动发起社交互动

1.在过去两周内，孩子主动与家庭成员发起聊天、游戏邀请等社交互动的平均每周次数大约是？

A. 几乎没有（0 - 1 次）

B. 很少（2 - 3 次）

C. 偶尔（4 - 6 次）

D. 经常（7 - 9 次）

E. 频繁（10 次及以上）

2.在学校里，孩子主动与同学发起互动（如课间交流、一起做活动等）的平均每周次数大概是？

A. 几乎没有（0 - 1 次）

B. 很少（2 - 3 次）

C. 偶尔（4 - 6 次）

D. 经常（7 - 9 次）

E. 频繁（10 次及以上）

3.孩子主动发起社交互动的对象通常是？（可多选）

A. 父母

B. 兄弟姐妹

C. 特定的某位家庭成员

D. 熟悉的同学

E. 不同的同学

F. 几乎不主动与任何人互动

三、对他人社交信号的回应能力

中国知网　https://www.cnki.net

1.当家庭成员与孩子说话、打招呼或发出邀请时，孩子能够及时回应（如眼神对视、言语回应、行动回应等）的比例大概是？

A. 几乎从不（0 - 20%）

B. 很少（21% - 40%）

C. 有时（41% - 60%）

D. 经常（61% - 80%）

E. 总是（81% - 100%）

2.在学校，面对同学的互动请求（如一起玩游戏、讨论问题等），孩子能够给予恰当回应（积极参与、合理拒绝等）的比例约为？

A. 几乎从不（0 - 20%）

B. 很少（21% - 40%）

C. 有时（41% - 60%）

D. 经常（61% - 80%）

E. 总是（81% - 100%）

3.当他人表现出不同情绪（如高兴、难过、生气等）时，孩子能够察觉并做出相应反应（如安慰、分享喜悦等）的情况如何？

A. 几乎没有察觉和反应

B. 偶尔能察觉，但不知如何反应

C. 有时能察觉并做出简单反应

D. 经常能察觉并做出较恰当反应

E. 总是能敏锐察觉并做出合适反应

四、与家庭成员和同学相处的融洽程度

1.在家庭日常活动中（如吃饭、看电视、外出等），孩子与家庭成员相处的和谐程度如何？

A. 经常发生冲突，很难和谐相处

B. 偶尔会有矛盾，总体相处一般

C. 大部分时间相处融洽，偶尔有小摩擦

D. 基本能和谐相处，很少有不愉快

E. 相处非常融洽，关系亲密

2.在学校课间休息、集体活动等场景中，孩子与同学的相处状态是？

A. 经常被孤立或与同学发生冲突

B. 偶尔与同学有矛盾，不太融入集体

C. 能参与集体活动，但与同学交流较少

D. 与部分同学关系较好，能较好融入集体

E. 与大多数同学关系融洽，积极参与集体活动

中国知网 https://www.cnki.net

3.孩子与家庭成员 / 同学产生矛盾后，通常的解决方式是？（可多选）

A. 哭闹、发脾气，无法解决

B. 不理会对方，矛盾持续

C. 在他人调解下解决

D. 自己尝试与对方沟通解决

E. 很少产生矛盾

五、语言表达和沟通能力的提升情况

1.与之前相比，孩子在家庭中表达自己想法、需求和感受时的语言流畅度和清晰度变化如何？

A. 几乎没有变化，表达仍很困难

B. 有轻微改善，表达仍不顺畅

C. 有一定进步，能较清楚表达基本想法

D. 进步明显，能清晰流畅地表达复杂想法

E. 表达能力与正常儿童无异

2.在学校课堂发言、与老师同学交流时，孩子语言表达的自信程度和沟通效果有何变化？

A. 几乎没有变化，发言很少且不自信，沟通效果差

B. 有轻微改善，发言稍积极但仍不自信，沟通有障碍

C. 有一定进步，能较自信发言，沟通基本顺畅

D. 进步明显，自信大方发言，沟通效果良好

E. 语言表达和沟通能力与正常同学相当

3.孩子在对话中能够理解他人话语含义，并做出合适回应的能力表现如何？

A. 经常误解他人意思，回应不恰当

B. 有时能理解简单话语，复杂的就不行

C. 大部分日常话语能理解并恰当回应

D. 能很好地理解他人话语，回应准确恰当

E. 理解和回应能力与正常儿童一样

六、刻板行为对日常生活的影响程度

1.孩子是否存在刻板行为（如重复特定动作、坚持固定顺序、痴迷特定事物等）？

A. 是

B. 否（若选 “否”，可直接跳至第 4 题）

2.这些刻板行为在家庭日常生活（如吃饭、穿衣、玩耍等）中出现的频繁程度是？

A. 几乎时刻都在发生

中国知网　https://www.cnki.net

B. 经常发生，每天多次
C. 偶尔发生，每周几次
D. 很少发生，每月几次
E. 几乎不发生

3.刻板行为对孩子家庭日常生活的干扰程度如何？
A. 严重干扰，导致日常生活难以正常进行
B. 较大干扰，影响部分日常活动
C. 有一定影响，但尚可应对
D. 影响较小，不怎么妨碍日常生活
E. 几乎没有影响

4.在学校环境中，孩子刻板行为出现的频繁程度是？
A. 几乎时刻都在发生
B. 经常发生，每天多次
C. 偶尔发生，每周几次
D. 很少发生，每月几次
E. 几乎不发生

5.刻板行为对孩子在学校学习和社交活动的影响程度如何？
A. 严重影响，无法正常参与学习和社交
B. 较大影响，学习和社交活动受到明显阻碍
C. 有一定影响，需要老师同学较多关注
D. 影响较小，基本不影响正常学习社交
E. 几乎没有影响

再次感谢您的支持与配合！您的反馈对我们了解孩子的社交发展情况非常重要。如果您对问卷内容或孩子的情况有任何疑问或补充信息，欢迎随时与我们联系。

联系电话：_____
电子邮箱：_____

中国知网 https://www.cnki.net

附录 B　社交反应量表-自闭症儿童社交反应量表

一、量表说明

本量表旨在评估自闭症儿童在社交情境中的反应表现，从社交互动、社交沟通、社交意识、社交认知以及刻板行为对社交的影响等维度进行测量，以便更全面、准确地了解自闭症儿童的社交状况，为介入措施的制定与效果评估提供参考依据。量表采用 5 级评分制，1 表示 “几乎从不”，2 表示 “很少”，3 表示 “有时”，4 表示 “经常”，5 表示 “几乎总是”。请根据您对自闭症儿童日常表现的观察进行作答。

二、量表内容

（一）社交互动

1.在集体活动中，孩子主动参与互动的频率如何？

2.面对他人主动发起的互动邀请，孩子能够积极回应的情况怎样？

3.孩子与同伴进行眼神接触的持续时间和频率如何？

4.孩子在与他人互动时，会主动做出肢体动作（如牵手、拥抱等）来表达友好的程度如何？

5.在游戏等互动情境中，孩子能与同伴共同遵循游戏规则进行互动的情况如何？

（二）社交沟通

1.孩子在日常交流中，主动发起话题的频率如何？

2.当他人说话时，孩子能够专注倾听并做出适当回应（如点头、简短回答等）的情况怎样？

3.孩子在表达自己的想法和需求时，语言表达清晰、流畅，让他人能够理解的程度如何？

4.在对话过程中，孩子能够根据对方的话题进行合理延续和拓展的能力怎样？

5.孩子在理解他人话语中的隐含意义（如玩笑、讽刺等）方面的表现如何？

（三）社交意识

1.在社交场合中，孩子能够敏锐察觉到他人情绪变化（如高兴、难过、生气等）的情况如何？

2.孩子是否能够意识到自己的行为对他人产生的影响（如打扰到别人、让别人开心等）？

3.在不同社交场合（如学校、家庭聚会、公共场所等），孩子能遵循相应社交规则（如保持安静、排队等）的程度如何？

中国知网　https://www.cnki.net

4.当与他人发生冲突时，孩子能意识到冲突存在并尝试解决的情况怎样？

5.孩子对周围社交环境中的变化（如人员的增减、场景布置的改变等）的关注度如何？

（四）社交认知

1.孩子对不同社交角色（如父母、老师、朋友等）的职责和特点的理解程度如何？

2.在故事或现实情境中，孩子能够推断他人的意图和想法的能力怎样？

3.孩子是否明白不同社交情境下应有的行为规范和礼仪（如见面打招呼、分别说再见等）？

4.当看到他人的行为时，孩子能从他人的角度去理解该行为原因的情况如何？

5.孩子对社交活动中的因果关系（如因为分享玩具，所以朋友更愿意一起玩）的认知水平如何？

（五）刻板行为对社交的影响

1.孩子的刻板行为（如重复性摇晃身体、旋转物品等）在社交场合中出现的频率如何？

2.刻板行为的出现是否明显干扰了孩子与他人的正常社交互动？

3.当他人试图阻止或引导孩子停止刻板行为时，孩子的配合程度如何？

4.孩子是否因为刻板行为而难以参与到需要合作或互动的社交活动中？

5.刻板行为的持续时间和强度对孩子建立和维持社交关系的影响程度如何？

中国知网 https://www.cnki.net

附录 C　满意度调查表-自闭症儿童社交介入满意度调查表

尊敬的家长：

您好！非常感谢您和孩子参与本次自闭症儿童社交介入项目。为了不断提升我们的服务质量，更好地帮助自闭症儿童改善社交能力，特开展此次满意度调查。您的反馈对我们至关重要，请您根据实际感受如实填写以下内容。本调查为匿名形式，您无需有任何顾虑。

一、基本信息

1.您孩子参与介入项目的时长：

A. 4 个周以下

B. 5 - 8 个周

C. 9 - 12 个周

D. 13-16 个周

2.您孩子的年龄：_____

二、介入方法效果

1.您认为应用行为疗法结合小组工作对孩子社交能力的提升效果如何？

A. 非常显著，孩子在多个社交方面有明显进步

B. 比较显著，在部分社交领域有较大改善

C. 有一定效果，能看到一些细微变化

D. 效果不明显，孩子社交能力变化不大

E. 不清楚

2.在改善孩子社交互动异常方面，您对介入方法的满意度为：

A. 非常满意，孩子现在能主动参与更多社交互动

B. 满意，相比之前有积极改变

C. 一般，有一定效果但还需改进

D. 不满意，几乎没有改善

E. 非常不满意，没有看到任何积极变化

3.对于提升孩子社交沟通能力，您觉得介入方法的成效如何？

A. 成效显著，孩子表达更清晰，沟通主动性增强

B. 有成效，沟通技巧有所提升

C. 效果一般，沟通方面进步不明显

D. 效果较差，与预期差距较大

E. 没有效果

4.在增强孩子社交意识和提高社交认知方面，您对介入方法的评价是：

中国知网　https://www.cnki.net

A. 效果很好，孩子能更好地理解他人和社交场景

B. 较好，有一定程度的提高

C. 一般，效果不太突出

D. 较差，几乎没有提升

E. 完全没有效果

三、小组活动组织

1.小组活动的内容和形式是否符合您孩子的特点和需求？

A. 完全符合，孩子很感兴趣且积极参与

B. 比较符合，大部分活动对孩子有帮助

C. 基本符合，部分活动可进一步优化

D. 不太符合，很多活动孩子参与度不高

E. 完全不符合

2.小组活动的频率安排是否合理？

A. 非常合理，既保证了介入效果又不过度疲劳

B. 合理，孩子能较好适应

C. 一般，稍微调整一下可能更好

D. 不合理，频率过高或过低

E. 非常不合理，严重影响孩子状态

3.活动场地和设施是否满足小组活动开展及孩子需求？

A. 完全满足，场地宽敞、设施齐全

B. 基本满足，有些小细节可以改进

C. 一般，场地或设施存在一定不足

D. 不满足，场地拥挤或设施缺乏

E. 非常不满足，严重影响活动进行

四、工作人员表现

1.介入人员对应用行为分析理论及小组工作方法的掌握程度如何？

A. 非常专业，能熟练运用并灵活调整

B. 比较专业，基本能满足介入需求

C. 一般，在某些方面还需要加强学习

D. 不太专业，感觉方法运用不够恰当

E. 很不专业

2.工作人员与孩子的沟通互动情况如何？

A. 非常好，孩子很喜欢与工作人员交流

B. 较好，能建立良好的关系并有效引导孩子

C. 一般，沟通互动比较平淡

中国知网 https://www.cnki.net

D. 较差，孩子对工作人员比较抵触

E. 非常差，几乎没有有效的沟通

3.工作人员对您的疑问和反馈的回应速度和态度如何？

A. 回应迅速且态度积极，能很好解决问题

B. 回应较快，态度也比较好

C. 回应速度一般，态度尚可

D. 回应较慢，态度不太积极

E. 很少回应，态度冷淡

五、总体满意度

1.您对本次自闭症儿童社交介入项目的总体满意度为：

A. 非常满意，超出预期

B. 满意，达到了预期效果

C. 一般，基本符合期望但有提升空间

D. 不满意，未达到期望

E. 非常不满意，失望

2.您是否愿意向其他有类似需求的家长推荐本介入项目？

A. 一定会，效果很好

B. 可能会，总体还不错

C. 不确定，看情况

D. 可能不会，存在一些问题

E. 一定不会，不太满意

六、意见与建议

您对本次自闭症儿童社交介入项目还有哪些其他的意见或建议？（可从介入方法、小组活动、工作人员等方面阐述）

再次感谢您的支持与配合！您的反馈将为我们后续工作的改进提供重要参考。

中国知网　https://www.cnki.net